SOPORTE DE AYUDA PARA EL ESTUDIO UF0129



U.F. 0129:

Animación social de personas dependientes en instituciones.

UNIDAD FORMATIVA 1: ANIMACIÓN SOCIAL PARA PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES (UF0129; 30 horas)



Contenidos:

1. Participación en la atención psicosocial de las personas dependientes en la institución sociosanitaria

La dinámica de grupos y la animación sociocultural serán las estrategias elegidas para promover la participación social de los usuarios en el contexto de la unidad residencial y para motivar a las personas dependientes y dirigirlas en la gestión y dirección de sus recursos propios. Bajo este marco, las actividades a desarrollar con las personas de la institución social serán diseñadas para la atención a las necesidades fundamentales del mantenimiento de la autonomía motora, afectiva, cognitiva y social, de modo que asuman responsabilidades en el proceso de mantenerse activos e independientes.

1.1.- Fomento de la adaptación a la institución de las personas dependientes:

Para cualquier persona, cambiar de domicilio y de personas que le cuidan es un paso muy importante. Fácilmente, si no se hace con cuidado, se genera desconfianza, desorientación, depresión.

Debemos tener presente que, generalmente, hasta el momento de su llegada al centro, la persona mayor ha vivido sola en su casa, o cuidada por sus familiares, con los cuales tiene fuertes vínculos afectivos.

Características.

CONTEXTO FÍSICO Y SOCIAL

El contexto físico y social del centro puede contribuir a que la persona sea más dependiente o más autónoma.



El profesional interviene sobre las condiciones ambientales del centro, haciéndolo accesible para todos las personas usuarias. Algunas enfermedades de tipo orgánico complican la situación que padecen personas con discapacidad física. En estos casos, ofrecer ayudas técnicas o adaptar funcionalmente el entorno, disminuye la situación de dependencia, esto es, se realizan adaptaciones para la movilidad funcional.

CONTEXTO PSICOLÓGICO

La confusión mental o los estados de agitación son frecuentes eb los ingresos en las instituciones. En estos casos, se trata de que el ambiente físico facilite la adaptación y orientación espacial y personal. Colocando relojes en la pared, calendarios con caracteres de gran tamaño o cuidando que las instalaciones se encuentren bien iluminadas, por ejemplo, atendemos las necesidades relacionadas con los factores psicológicos.

CONTEXTO SOCIAL

Asimismo, la calidad de las relaciones entre los residentes, o incluso entre los pacientes y el personal cuidador, facilita o dificulta la adaptación personal. Con la intención de facilitar la adaptación de las personas y atender las necesidades de interacción social, la institución planifica un programa de animación psicosocial que contempla:

- La creación de hábitos y rutinas que estimulan a los pacientes.
- La planificación de actividades que atienden las áreas de interés de los usuarios.
- La participación activa en distintas situaciones sociales (fiestas, excursiones, etc.)

Factores que favorecen o dificultan la adaptación.

El ingreso es un cambio importante en la vida de las personas y su adaptación es difícil siempre, pues supone someterse a la institución pero hay una serie de factores que facilitan la adaptación de la persona usuaria y otros que la dificultan.

FACTORES QUE FAVORECEN LA ADAPTACIÓN

Entre otros tenemos que:

- Preparación previa al ingreso del usuario, explicarle las causas de su nueva circunstancia, plantearle previamente cual va a ser su nueva situación. Dejarle que exponga sus dudas, miedos… y tranquilizarle dándole el máximo de información que solicite.
- Estado físico y psíquico óptimo del residente.
- Interés en el ingreso.
- Protocolo de acogida actualizado
- características del centro.
- Mayor o menor duración del ingreso.
- Grado de apoyo familiar.
- Profesional del equipo de asistentes
- Relaciones interpersonales fluidas y afectivas con el resto de compañeros y profesionales del centro.
- Relaciones con la familia: Implicación y participación de las familias en las actividades y vida del centro.
- Relaciones con la comunidad: Participación e integración en actividades sociocomunitarias (fiestas locales, conferencias, seminarios, actividades de las asociaciones de voluntariado).

FACTORES QUE DIFICULTAN LA ADAPTACIÓN

- Todo aquello que facilita y no se da es un factor que dificulta la adpatacion.
- La persona usuaria no haya sido informada de su ingreso, se siente engañada y abandonada, crece el recelo
- desinterés en el ingreso
- Estado físico y psíquico del residente también puede resultar un hándicap
- Carecer de un protocolo de acogida implantado
- Sentir añoranza por la antigua vida, la familia, las relaciones sociales hace que no se establezcan nuevos vínculos.

Apoyo durante el periodo de adaptación.

El proceso de adaptación a la institución sociosantiaria o la aceptación de la institucionalización con carácter permanente pueden resultar unas experiencias dolorosas para algunas personas en situación de dependencia.

En la convivencia pueden desatarse situaciones de estrés cotidiano y es habitual que estos pacientes experimenten tensión emocional por lo que, como cuidadores, resultará fundamental ser un apoyo afectivo y buscar en el trabajo diario momentos para conversar con los usuarios y valorar cómo se encuentran de ánimo. De esta forma, detectaremos pensamientos, emociones y conductas que nos llamarán la atención por no ser habituales en esa persona en concreto. Aunque nuestra labor no sea la de realizar una exploración clínica, debemos valorar en qué estado se halla su capacidad física, mental e, incluso, su nivel de respuesta afectiva: pensemos por ejemplo en la importancia de detectar a tiempo en un paciente dependiente ideas suicidas. Debemos tener una mirada completa de la persona y observarla en diversas circunstancias, y especialmente si aparecen cambios repentinos en su carácter, en su apariencia física o en su comportamiento social.

Podemos valorar la reactividad emocional, entendida como la tensión experimentada y subjetiva que siente una persona en situaciones sencillas y que puede afectarle tanto negativa como positivamente.

Para ello, observaremos si el usuario es capaz de sonreír cuando le gastamos una broma, si ríe o llora indistintamente con la misma intensidad sin causa aparente,… también prestaremos atención a qué nos cuenta y cómo, etc. En función de la valoración realizada incorporaremos actuaciones personalizadas teniendo en cuenta que el ingreso en un centro con frecuencia es vivido como un proceso largo.

La adaptación a la institución sociosantiaria comienza en la primera toma de contacto con el centro (que suele ser junto a la familia) y acaba cuando el usuario se encuentra en sintonía con el entorno donde vive. En la mayoría de los casos exige al residente una acomodación casi continua y diaria, tanto por las modificaciones en su estado de salud como por los cambios que pueden surgir en la institución social.

Estrategias de intervención.

Las estrategias de intervención durante el proceso de adaptación se recogen en los Planes de Intervención.

El Plan se configura, como sistema de intervención global con el conjunto de programas interrelacionados, dirigidos a los objetivos anteriores, a través de los cuales se organizan y gestionan todos los servicios y práctica asistencial en las diversas áreas (salud, integración social, relación familiar, actividades…) a aplicar de forma interdisciplinar e individualizada en las distintas y cambiantes situaciones personales.

Para ello, los programas deberán ser abiertos y flexibles, es decir, con capacidad de expansión y adaptación a una realidad social concreta y dinámica a la que atender en sus distintas dimensiones y en su misma dirección de cambio. Deberán además, como condición imprescindible, obedecer a unos principios y modelo de residencia, dentro de un plan global de intervención que les sirva de referencia.

En base a esta idea, se propone el siguiente programa de intervención:

Programas de intervención con la persona mayor: integran la atención directa interdisciplinar de apoyo y cuidados individualizados, incluyen:

- Apoyo a la Adaptación e Integración: organiza la intervención profesional al ingreso para facilitar su satisfacción en el medio residencial.
- Atención Sociosantiaria: ofrece cuidados en función de las necesidades individuales a través de programas generales y específicos (cuidados básicos de enfermería, rehabilitación, demencias, problemas sensoriales, terminales, etc.)
- Actividades terapéuticas: para el desarrollo de las capacidades personales mediante la participación grupal en diversas actividades de estimulación funcional, cognitiva y social.

Programas de intervención ambiental: son medidas en el ambiente físico y social facilitadoras de la autonomía, convivencia y desarrollo personal, incluyen:

- Adaptación del contexto físico: para ofrecer un espacio accesible, seguro, estimulante y agradable, que favorezca el confort y normal desenvolvimiento.
- Adaptación del ambiente social: organizando el funcionamiento del centro para tener un clima social participativo (residente-personal-familias) en unas fluidas relaciones democráticas, basadas en el respeto a los derechos personales.

Programas de Recursos Humanos: son la garantía de una atención profesional cualificada mediante la formación continuada del personal asistencial, el desarrollo del trabajo en equipo y otras medidas dirigidas hacia una mayor participación y satisfacción profesional.

Programas de intervención con la familia son actuaciones dirigidas a la implicación de la familia como agente de intervención en la residencia:

- Apoyo familiar: se centra en favorecer, a nivel individual, la implicación de la familia como vínculo afectivo y cuidador natural en la atención residencial.
- Participación familiar en el centro: para impulsar la colaboración familiar, a nivel colectivo, como grupo con intereses comunes, desarrollando cauces de participación efectiva en la residencia (asociacionismo).

Programas de integración comunitaria son los que se organizan, mediante la coordinación comunitaria, la colaboración con los diversos servicios del contexto social para la mejor atención e integración social de los mayores en una optimización de los recursos comunitarios:

- Actividades de Integración social: incluye diversas actividades de animación sociocultural al objeto de mantener la participación social en la comunidad.

- Apoyo a los Mayores de la Comunidad: ofrece servicios desde las residencias para el mantenimiento de la persona mayor en su entorno habitual.
- Colaboradores Sociales: pretende potenciar y organizar la labor de apoyo de colaboración social en la residencia, complementaria al trabajo de los profesionales.

1.2.- Fomento de la relación social de las personas dependientes:

Uno de los objetivos de las residencias de ancianos consiste en suministrar oportunidades para la interacción social y el apoyo mutuo entre los ancianos residentes.

El entrenamiento en habilidades sociales constituye un procedimiento básico de tratamiento para conseguir una relación eficaz y satisfactoria con los demás

Características.

La habilidad social podría ser definida como son un conjunto de conductas, puestas de manifiesto en las relaciones con otras personas que dotan a la que las posee de una mayor capacidad para lograr los objetivos que pretende, manteniendo su autoestima sin dañar la de las personas que la rodean., o si se prefiere, es una clase de respuestas pertinentes para desempeñar con eficacia las siguientes funciones:

- Conseguir reforzadores en situaciones de interacción social.
- Mantener ó mejorar la relación con otra persona en la interacción interpersonal.
- Impedir el bloqueo del refuerzo social ó mediado socialmente.
- Mantener la autoestima y disminuir el estrés asociado a situaciones interpersonales conflictivas.



Para la comprensión y la adecuada concepción de las habilidades sociales, es necesario considerar algunas de sus características. Se pueden destacar las siguientes:

1) Son conductas y repertorios de conducta adquiridos a través del aprendizaje. No son rasgos de personalidad, se adquieren a través del aprendizaje y, por tanto, se pueden cambiar, enseñar o mejorar mediante los mecanismos del aprendizaje.

2) Constituyen habilidades que ponemos en marcha en contextos interpersonales, esto es, requieren que se produzca una interacción. No incluyen otras habilidades de adaptación social como las habilidades de autocuidado (lavarse, vestirse), de vida en el hogar (limpiar, planchar, cocinar) o de vida en la comunidad (orientación, desplazarse, utilizar el transporte), sino que, al igual que estas, constituyen una de las áreas del comportamiento adaptativo. Sin embargo, es habitual encontrar manuales de entrenamiento en habilidades sociales que incluyen habilidades como vestirse, preparar alimentos u orientarse en el espacio, que, si bien son habilidades de adaptación social relacionadas, no son estrictamente habilidades sociales.

3) Son, por tanto, recíprocas y dependientes de la conducta de las otras personas que se encuentren en el contexto. Por ello, requieren la puesta en marcha de habilidades de iniciación y de respuestas interdependientes dentro de una reciprocidad e influencia mutuas. Así, la persona se ve influida por los demás y también influye sobre los otros para que modifiquen sus conductas.

4) Contienen componentes manifiestos observables, verbales (preguntas, autoafirmaciones, alabanzas, peticiones) y no verbales (mirada, gestos, sonrisa, orientación, expresión facial, expresión corporal, distancia-proximidad), y otros *componentes cognitivos y emocionales* (conocimiento social, capacidad de ponerse en el lugar de otras personas, capacidad de solucionar problemas sociales, constructos personales, expectativas, planes y sistemas de autorregulación) y *fisiológicos* (tasa cardiaca, respiración, presión sanguínea, respuestas electrodermales). La habilidad social es lo que la persona dice, hace, piensa y siente.

5) Aumentan el refuerzo social y la satisfacción mutua. Disponer y manifestar un repertorio adecuado de habilidades sociales hace que la persona obtenga más refuerzo de su ambiente, y permite también que la interacción proporcione satisfacción a quienes forman parte de esta.

6) Las habilidades sociales son específicas de la situación. Ninguna conducta en sí misma es o no socialmente habilidosa, sino que depende del contexto, de la situación y de sus reglas, de las personas con las que se interactúa, del sexo, de la edad, de los sentimientos de los otros, etc. Por ello, para que una conducta sea socialmente hábil, es necesario que la persona, además de motivación o metas sociales, tenga capacidad de *percibir* la información básica de dicho contexto o situación (percepción de indicadores verbales y no verbales, ambiente físico). Debe también ser capaz *de procesar esa información* en base a la experiencia, la

observación, el aprendizaje y la maduración (interpretación de reglas de la situación, de los sentimientos y los deseos de los demás). Asimismo, ha *de actuar* sobre ella poniendo en acción secuencias adecuadamente ordenadas de conductas verbales y no verbales apropiadas. Por último, ha de *evaluar, controlar y regular* su conducta a través del *feedback externo* (verbal y no verbal) y de la *evaluación interna* (cogniciones, emociones).

7) Es importante la existencia de metas, propósitos o motivación social para desarrollar un adecuado repertorio de habilidades sociales.

Habilidades sociales fundamentales.

Las personas reconsideran agentes activos porque no sólo se influencian por los demás, sino que también influyen sobre éstos.

De tal modo, se considera que una conducta será socialmente hábil siempre y cuando sepa adaptarse a las demandas de la situación social.

Las habilidades sociales tienen tres componentes:

- La capacidad de percibir los estímulos del entorno, en lo referente a otras personas como en lo referente al ambiente
- La capacidad de elaborar respuestas acordes a os estímulos percibidos.
- La capacidad de expresar correctamente las respuestas elaboradas.

Las habilidades sociales pueden enunciarse y describirse. Veámoslas:

El lenguaje no verbal

- La expresión de la cara.

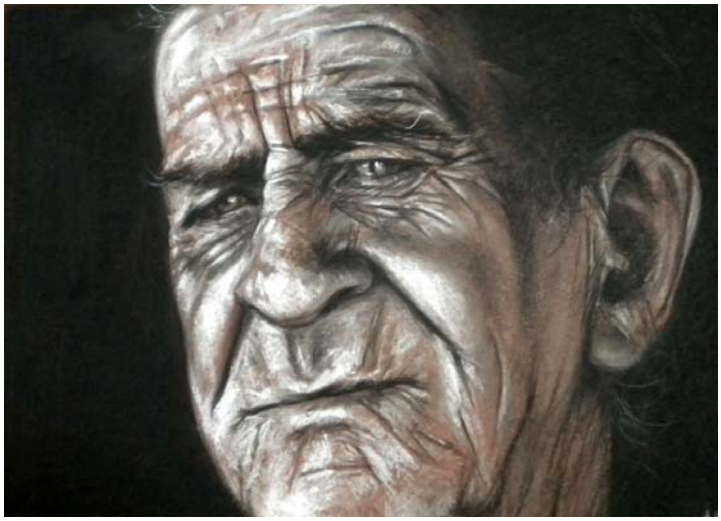
El rostro expresa las seis emociones fundamentales: miedo, rabia, desprecio, alegría, tristeza y sorpresa. Y hay tres zonas de la cara que representan estas emociones: la frente con las cejas, los ojos y la



zona inferior de la cara.

- La mirada.

Mirar a los ojos o a la zona superior de la cara ayuda a establecer el contacto y dependiendo de cómo sean esas miradas se expresan las emociones: se considera más cercanas a las personas que miran más a su interlocutor, pero no si es de forma fija y dominante. Y mirar poco puede ser signo de timidez. La mirada acompaña a la conversación: si miramos cuando escuchamos animamos a la otra persona a comunicarse. En cambio, mirar a los ojos cuando hablamos convierte nuestro discurso en más convincente.



- La sonrisa

Una expresión sonriente casi siempre denota cercanía, suaviza tensiones y facilita la comunicación. Pero si el gesto sonriente expresa ironía o escepticismo puede manifestar rechazo, indiferencia o incredulidad. La postura corporal. Los gestos del cuerpo expresan cómo se siente interiormente la persona según sea su manera de sentarse, de caminar... Se pueden trasmitir escepticismo (encogiéndose de hombros), agresividad (apretando los puños), indiferencia (sentándonos casi tumbados cuando alguien nos habla). La distancia física entre personas que se comunican también indica la proximidad emocional entre esos individuos. Dos cuerpos cercanos expresan proximidad afectiva. Volver la espalda o mirar hacia otro lado es una manifestación de rechazo o desagrado. Un cuerpo contraído expresa decaimiento y falta de confianza en uno mismo; y un cuerpo expandido, todo lo contrario.

- La postura corporal.

Los gestos del cuerpo expresan cómo se siente interiormente la persona según sea su manera de sentarse, de caminar... Se pueden trasmitir escepticismo (encogiéndose de hombros), agresividad (apretando los puños), indiferencia

(sentándonos casi tumbados cuando alguien nos habla). La distancia física entre personas que se comunican también indica la proximidad emocional entre esos individuos. Dos cuerpos cercanos expresan proximidad afectiva. Volver la espalda o mirar hacia otro lado es una manifestación de rechazo o desagrado. Un cuerpo contraído expresa decaimiento y falta de confianza en uno mismo; y un cuerpo expandido, todo lo contrario.

Los que se producen con las manos y la cabeza acompañan y enfatizan lo que se comunica con la palabra o el silencio.

La expresión oral



La voz acompaña, y más de lo que pensamos, a la palabra. Las mismas palabras con entonación diferente trasmiten sentimientos tan distintos como ironía, ira, excitación, sorpresa o desinterés. Un tono mortecino es señal de abatimiento o depresión. Una conversación que se mantiene siempre en el mismo tono resulta monótona y aburrida y suscita poco interés. Se hace oír más, comunica mejor, la persona que juega con las modulaciones de voz a lo largo de su charla. El tono, que tan poco cuidamos normalmente, es a veces tan importante como el propio contenido de nuestras palabras.

Un volumen alto de voz expresa seguridad y dominio de la situación, pero cuando se eleva demasiado puede suscitar rechazo y connotar agresividad. El volumen bajo, por su parte, puede sugerir estados de ánimo como debilidad o falta de confianza en uno mismo pero también confidencialidad y cercanía. La fluidez de la palabra y el ritmo.

La utilización de repeticiones, muletillas, frases hechas y de relleno y los titubeos producen impresión de inseguridad, monotonía e incluso desconcierto en quien escucha.

Todos estos elementos de conducta relacional son herramientas de nuestra forma de estar en sociedad, y, bien articulados, nos ayudan a relacionarnos de forma más eficiente. Las habilidades sociales son conductas aprendidas y, por tanto, podemos mejorarlas. Facilitan la relación con otras personas y nos ayudan a ser más nosotros mismos, reivindicando nuestros derechos y peculiaridades sin negar los

derechos de los demás. Lo más positivo es que facilitan la comunicación y la resolución de problemas con otras personas.

La asertividad

El arte de convivir con los demás consiste en no quedarse corto y en no pasarse. Es un equilibrio entre ambos extremos, lo que se conoce como asertividad: ser nosotros mismos y resultar convincentes sin incomodar a los demás, al menos no más de lo imprescindible. La persona persuasiva, eficaz en su comunicación y que resulta agradable a sus interlocutores puede considerarse asertiva. Veamos lo que entendemos por quedarse corto y por pasarse.

- Quedarse corto.

Actitudes pasivas. Incapacidad para expresar con libertad lo que se siente, la propia opinión. Pedir disculpas constantemente. Es la falta de respeto hacia las propias necesidades. El individuo pasivo trata de evitar los conflictos, al precio que sea. Quien actúa así no hace comprender sus necesidades y termina sintiéndose marginada y mostrándose irritada por la carga de frustración acumulada. Tampoco para sus interlocutores es fácil la situación de adivinar qué desea el pasivo y termina por considerarlo como una persona molesta.

- Pasarse.

Son las conductas agresivas e inadecuadas, avasallar los derechos de los demás por la defensa de los propios. Estas conductas agresivas pueden incluir desconsideraciones hacia el otro, insultos, amenazas y humillaciones e incluso ataques físicos. Tampoco falta la ironía y el sarcasmo despectivo. Se tiende a la dominación, a negar al otro la capacidad de defenderse, de responder equitativamente. Las consecuencias, a largo plazo, siempre son negativas incluso para el agresor que se queda sin amigos por mucho que pueda haber ganado súbditos.

La conducta asertiva es la más hábil socialmente porque supone la expresión abierta de los sentimientos, deseos y derechos pero sin atacar a nadie. Expresa el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Pero aclaremos que ser asertivo no significa la ausencia de conflicto con otras personas, sino el saber gestionar los problemas cuando surgen.

Junto con estas habilidades también están estas otras, tales como:

Habilidades elementales:

- Escuchar al otro. Trabajar la capacidad de comprender lo que me están comunicando

- Aprender a iniciar una conversación y a mantenerla
- Aprender a formular preguntas
- Saber dar las gracias
- Presentarse correctamente ataviado
- Saber presentarnos a otros y presentar a los demás
- Saber hacer un cumplido, sin zalamerías y con afecto.

Habilidades avanzadas:

- Aprender a pedir ayuda
- Capacitarnos para dar y seguir instrucciones
- Saber pedir disculpas
- Aprender a convencer a los demás, a ser persuasivo.

Habilidades relacionadas con los sentimientos:

- Conocer nuestros sentimientos y emociones y saber expresarlos
- Comprender, valorar y respetar los sentimientos y emociones de los demás
- Saber reaccionar ante el enfado del interlocutor y gestionar bien la situación
- Resolver las situaciones de miedo.

Habilidades alternativas a la agresividad

- Pedir permiso
- Compartir cosas, sensaciones y sentimientos
- Ayudar a los demás
- Aprender a negociar, a consensuar, a llegar a acuerdos
- Recurrir al autocontrol en las situaciones difíciles
- Defender nuestros derechos cuando los veamos amenazados
- Responder a las bromas cuando proceda
- Rehuir las peleas, dialécticas y de las otras.

Factores.

En el desarrollo de las habilidades sociales influye:

- Factores Fisiológicos: Son reacciones físicas que se producen al interactuar socialmente, por ejemplo: sudoración, ritmo cardíaco, temblor de voz....
- El grado de deterioro físico y psicológico condiciona notablemente la capacidad de relación, la propia dependencia hace que a la



hora de establecer relaciones interpersonales no se sea autónomo, esto es no es uno el que escoge.
- La pérdida de roles, se pasa de ser gestor de tus relaciones (trabajador, padre/madre de la familia) a depender de los que él ha cuidado.
- Las pérdidas afectivas (pareja, amigos, compañeros de partida…) que obligan a establecer nuevas relaciones para evitar el aislamiento.
- La situación económica
- La situación social previa al ingreso

Dificultades.

Durante la vejez, los deterioros psicofísicos, de origen múltiple y no siempre bien establecidos, son notables, como ocurre con el vértigo, los mareos, en general que pueden ser muy molestos e incapacitantes para el anciano, sumiéndole en un estilo de vida retraído y temeroso, que implica deterioros de la comunicación, la relación, y en suma, el padecimiento de situaciones de soledad

La pérdida de roles, la muerte de familiares, pareja y/o amigos, y el efecto de nido vacío conducen al aislamiento y deterioro de las relaciones sociales.

Las pérdidas afectivas que acontecen en la vejez, suelen tomarse como algo lógico e inevitable y no se les da importancia, cuando en realidad sabemos que las depresiones del anciano suelen ser desencadenadas por problemas de índole psicosocial, como son la pérdida de relaciones, cambios en la estructura familiar etc.

Dado que el aislamiento progresivo en el que sumergen los ancianos, independientemente de cuales sean sus causas, interfieren en la salud mental (depresión) y en la calidad de vida de los mismos se considera que el desarrollo de nuevas amistades y contactos sociales, paliará tales efectos.

Por lo tanto, la relevancia del entrenamiento en habilidades sociales radica en su utilidad para establecer y mantener nuevas relaciones sociales lo que favorecerá la salud mental y calidad de vida de los ancianos.

Técnicas para favorecer la relación social.

Algunos afortunados tienen las habilidades sociales de forma natural, casi innata, y las aplican cotidianamente sin esfuerzo alguno. Pero a pesar de este hecho, se puede también aprender a comunicarse mejor, esto es son conductas que se pueden aprender, sin que ello signifique menospreciar su personalidad que, sin duda, se verá nítidamente reflejada en los posibles cambios que introduzcamos en la manera de comportarnos con los demás.

Hay técnicas que favorecen la adquisición de nuevas habilidades sociales, las TERAPIAS SOCIALIZADORAS. Algunas de ellas son:

Ergoterapia



Es el conjunto de actividades manuales que se dirigen a favorecer la motivación y participación de los usuarios integrándolos en el contexto de una actividad lúdica, grupal y creativa.

En esta terapia además de ocupar el tiempo libre, orientando su ocio y favoreciendo sus gustos y aficiones se desarrollar las relaciones interpersonales que favorecen la integración social. Sirven a su vez de complemento a la rehabilitación física

Se trabaja a través de las técnicas específicas propias de cada actividad manual adaptando las tareas a las posibilidades manipulativas de cada usuario/a.

Son apropiadas actividades manuales diversas como la elaboración de productos artesanales, pintura, costura, realización de murales y collages, cerámica, etc.

Musicoterapia

Es el conjunto de actividades que utilizan el estímulo musical como herramienta terapéutica (ritmo, sonido, música, canto...) y se dirigen a proporcionar una estimulación sensorial adecuada para la mejora del estado psicoafectivo a la vez que potencian la dimensión relacional.

Se estimula la actividad mental, se fomenta la expresividad y se potencia la capacidad relacional

La musicoterapia incluye contenidos como los siguientes:

- Actividades de producción de sonido
- Actividades de producción de música

- Actividades de canto
- Actividades de ritmo
- Actividades de movimiento con música: desplazamientos, baile..
- Actividades de discriminación, rememoración y escucha musical



Ludotera

Es una selección de juegos, de interior y aire libre, que con las adaptaciones precisas se dirigen a favorecer la dimensión relacional, la de entretenimiento así como a proporcionar estimulación física y mental al usuario.



Fomentan la motivación hacia la actividad en el tiempo libre y potencian la capacidad relacional.

Los juegos deben presentar las siguientes características:

- estar adaptados al nivel psicofuncional del grupo,
- no infantilizar a la persona mayor
- no poseer un excesivo nivel de competitividad
- responder a los intereses de los participantes resultando lúdicos.

Pueden ser apropiados los siguientes juegos: Bingo o lotería, naipes, parchís, oca, dominó, petanca, bolos, puntería con aros, rana...

Grupos de habilidades sociales y comunicación

Son grupos estructurados donde, a través de diferente metodología y técnicas de intervención, se pretende mantener y/o mejorar las habilidades sociales y de comunicación de modo que se contribuya a favorecer cuantitativa y cualitativamente las relaciones sociales de los mayores.

Se utilizarán técnicas de dinámica de grupos, comunicación y modificación de conducta.

Los contenidos se relacionarán con la adquisición de repertorios de habilidades sociales básicas y la mejora de los procesos de comunicación interpersonal.

En este enlace puedes ver un video de una terapia grupal
http://www.youtube.com/watch?v=cSWjxtB0exo&feature=related

Grupos de conversación



Son grupos semiestructurados o informales donde se propicie la conversación y relación social entre los mayores para fomentar el contacto e interacción social espontánea y mantener las capacidades y habilidades relacionales.

Los contenidos de conversación se relacionarán con temas cotidianos y que sean de interés para los usuario/as. Se aprovecharán acontecimientos recientes, visitas, noticias del día... para dotar de contenido a las conversaciones.

Suele resultar interesante aprovechar momentos cotidianos para el desarrollo de estos grupos: el café, lectura o comentario de noticias, visitas de otros grupos al centro, acontecimientos especiales...

Estas son algunas técnicas utilizadas en las instituciones sociosanitarias pero existen otras más.

Actividades de acompañamiento y de relación social, individual y grupal.

La institución sociosanitaria dispone de diferentes servicios de asistencia y acompañamiento para la población usuaria, ofreciendo así el apoyo que los residentes necesitan para intentar conservar su independencia. Las actividades están organizadas en diversas áreas que pretenden atender a las necesidades fundamentales de las personas en situación de dependencia y, concretamente, al mantenimiento de su autonomía motora, afectiva, cognitiva y social.



El acompañamiento a los usuarios debe ser considerado una responsabilidad de todo el profesional sociosanitario. Cada profesional, desde su ámbito específico de intervención, se encarga de ofrecer a los usuarios diferentes actividades de acompañamiento diurno y nocturno en el hogar residencial, como visitas médicas, paseos, participación en prácticas religiosas, sesiones de lectura y entretenimiento, recordatorio de citas o toma de medicación, por ejemplo. Para conseguir este acompañamiento de una forma efectiva podemos utilizar muchas de las actividades que propone la animación social.

La animación social puede definirse como toda acción que ofrece a las personas dependientes las condiciones materiales y relacionales necesarias para que el individuo mantenga o

recupere las capacidades de autonomía que posee. Esta animación resultará efectiva si todo el personal del centro comparte unos mismos criterios respecto a una atención de calidad y entiende que estas actuaciones no son una parcela exclusiva del terapeuta ocupacional o del animador sociocultural.

Cuando aparecen limitaciones físicas o psíquicas tan severas que la dependencia compromete seriamente la autonomía, la ocupación del tiempo libre es mucho más complicada. En estos casos, las posibilidades de los usuarios se ven tan disminuidas que ya no son objeto de la animación sociocultural, sino de la terapia ocupacional.

La terapia ocupacional sería, el uso terapéutico de las actividades de autocuidado, trabajo y juego (ocio) para incrementar la función independiente, potenciar el desarrollo y prevenir la discapacidad. Puede incluir la adaptación de las tareas o del

entorno para lograr la máxima independencia y potenciar la calidad de vida”8. Así, esta terapia tiene como fin la estimulación, el mantenimiento y la recuperación de las capacidades funcionales con actividades como colorear dibujos, recortar papeles, recordar historias, hacer recopilación de acertijos, etc.

Medios y recursos: aplicaciones de las nuevas tecnologías, recursos del entorno.

LAS NUEVAS TECNOLÓGIAS



La aplicación de las nuevas tecnologías como recurso no esta muy extendida porque no están accesibles a personas que presentan características especiales, como discapacidad visual, auditiva, motriz, y también, ni a colectivos de personas mayores no acostumbrados a estos medios.

Implica que usen ordenadores, naveguen en la Red y practiquen ejercicios de manera sencilla e intuitiva, a pesar de no haber utilizado nunca esta tecnología.

Estas actividades ayudan a mantener y mejorar sus capacidades cognitivas.

Se pueden utilizar pizarras interactivas, por ejemplo para aprender a leer y a escribir en una pantalla táctil, ejercitar su memoria mediante ejercicios interactivos, etc.



Se necesita que los centros estén equipados con una serie de servicios adaptados,

proyectores, conexiones a Internet, pizarras interactivas…

La tecnología puede formar parte del día a día de estos mayores, se puede repasar la actualidad en los periódicos online mientras sus alumnos ven las noticias y las fotos de Internet en una gran pantalla para luego comentar los reportajes, reflexionan y debaten los temas de actualidad.

En el uso de las nuevas tecnologías destacan las actividades dirigidas a mantener y mejorar las capacidades cognitivas, memoria y atención de los mayores.

RECURSOS DEL ENTORNO

El aprovechamiento y utilización de los recursos del entorno se usan, igualmente, para la promoción de la autonomía de los residentes y la mejora de su calidad de vida. En este caso, actuaciones como las relaciones residentes del centro, con los servicios y actividades lúdicas que en este medio se pueden desarrollar, etc., promueven la autoestima del paciente y favorecen la mejora de sus capacidades relacionales.

La televisión puede ser una poderosa herramienta educativa, siempre que los programas, películas, vídeos, etc., que visionen los residentes mantengan un ajuste entre sus necesidades evolutivas y los contenidos a ver.

También son importantes la prensa y las revistas y deberemos facilitar el acceso de los usuarios a estas publicaciones periódicas, así como fomentar su interés por las mismas, ya que atienden a contenidos que les permitirán conocer noticias de actualidad.



La radio puede servirles de compañía en los momentos de soledad. El vídeo puede ser un instrumento útil al reproducir cintas con temas a su gusto y los reproductores de discos pueden permitir que la persona oiga música de su agrado.

Estos recursos deben ser un complemento a las tareas de ocupación personal y nunca serán empleados como sustitutivos de la actividad residencial ya que, en este supuesto, los instrumentos tecnológicos resultarían contraproducentes para el desarrollo integral de la persona.

La participación en grupos culturales, deportivos o de otro tipo supone una experiencia muy importante de integración social. Actividades en un entorno social cercano, como realizar compras en los comercios, tomar un café en un local del barrio, ir a misa a la iglesia, ver espectáculos o exposiciones culturales, participar en

las fiestas populares,… ayudarán a compensar la excesiva dependencia que algunas personas pueden desarrollar con respecto a la unidad residencial.

1.3.- Utilización del ambiente como factor favorecedor de la autonomía personal, comunicación y relación social:

Para un correcto desarrollo de las actividades planteadlas en los anteriores apartados se establecerán y desarrollarán medidas ambientales para procurar un ambiente físico que cumpla con las siguientes características:

- Orientador. Ofreciendo, de un modo especial para las personas con deterioro cognitivo, referencias que favorezcan la orientación espacial, temporal y personal.

- Seguro. Proporcionando, desde medidas individualizadas y ajustadas a las peculiaridades de cada centro, un ambiente seguro para la persona mayor.

- Confortable. Favoreciendo una decoración que proporcione un ambiente cálido, familiar, confortable, cuidando de un modo especial el respeto a la edad adulta de la persona mayor dependiente, y evitando, en consecuencia reproducir ambientes infantiles.

- Estimulador. Procurando una estimulación sensorial apropiada, evitando una inadecuación de la estimulación sensorial que puede proceder tanto del exceso como del defecto.

Elementos espaciales y materiales: distribución, presentación.

Lo fundamental es que la distribución de los elementos espaciales y materiales Haga que resulten accesibles.

Con carácter general hay que señalar que cada sala dispondrá del equipamiento necesario para el correcto desarrollo de los servicios y de los programas de intervención. Además, el equipamiento deberá estar adaptado a las necesidades de la persona mayor dependiente, y poseer las características ergonómicas que garanticen la seguridad del mismo. De un modo más específico cabe indicar respecto al equipamiento concreto de algunas estancias:

Sala de reposo: Contará con sillones o butacas cómodas que permitan el descanso.

Comedor con mesas y sillas en número suficiente proporcional a los usuarios. Existirá menaje accesible y ayudas técnicas si se precisan.

Salas polivalentes de actividades terapéuticas: Se concebirán espacios polivalentes que posibiliten ser utilizados para diversos programas de actividades, evitando

limitar salas a servicios exclusivos. Son aconsejables mesas modulares que permitan variar el tamaño del grupo en función de las actividades terapéuticas. Es adecuado que el mobiliario sea movible, es decir que permita ser desplazado para posibilitar actividades que requieran espacios libres.

Baños y aseos que tendrán el espacio y adaptaciones necesarias para el uso de personas con discapacidad física.

Material terapéutico

Cada centro dispondrá de su propio material terapéutico, independientemente de la obligación de las entidades o empresas de servicios en proporcionar un mínimo de material. Es tarea de los profesionales responsables de las diferentes terapias diseñar, elaborar y adaptar material terapéutico de interés. Desde la Consejería de Asuntos Sociales se promoverá el intercambio profesional y el conocimiento de material terapéutico considerado de interés.

Al igual que en la decoración, habrá que cuidar de un modo muy especial que el material utilizado sea propio de la edad adulta y no infantilice a la persona mayor.

Algunos ejemplos de materiales podrían ser:

- Etiquetas con ilustraciones para estructurar el ambiente de la residencia; por ejemplo, una imagen de un inodoro en la puerta del cuarto de baño junto a las letras WC.
- Horarios de las actividades diarias.
- Calendarios con imágenes y fechas señaladas.
- Carteles con dibujos de las actividades de tiempo libre.
- Iconos y señales con ayudas para explicar las normas de la institución (como una señal de “prohibido” para indicar “no pasar”).
- Cuadernos de tareas, que consisten en una selección de imágenes con instrucciones concretas como ayuda para el manejo del grupo en los talleres o para el desarrollo de las actividades.

Decoración de espacios.

La decoración de los espacios, incluyendo los colores, también influyen en el estado de ánimo de las personas. La decoración de la institución debe ser equilibrada y funcional, debe procurar transmitir una sensación acogedora.

En los espacios comunes podemos utilizar las manualidades y elementos realizados por los usuarios para decorar, de esta forma los usuarios sentirán más suyos y familiares los espacios. Aumentando así sentimientos de pertenencia y seguridad al centro. Tendremos por tanto, que motivar a los residentes a colaborar en la decoración de dichos espacios, aprovecharemos cambios de estación, festividades señaladas...

Es fundamental la participación de la persona usuaria en la decoración de su espacio personal. Los objetos personales en su habitación, fotografías, ropa de cama, cuadros... darán como resultado un ambiente más familiar y seguro. Los colores deben ser cálidos, suaves y luminosos, de esta forma crearemos un entorno tranquilo y agradable.



Diseño y elaboración de materiales.

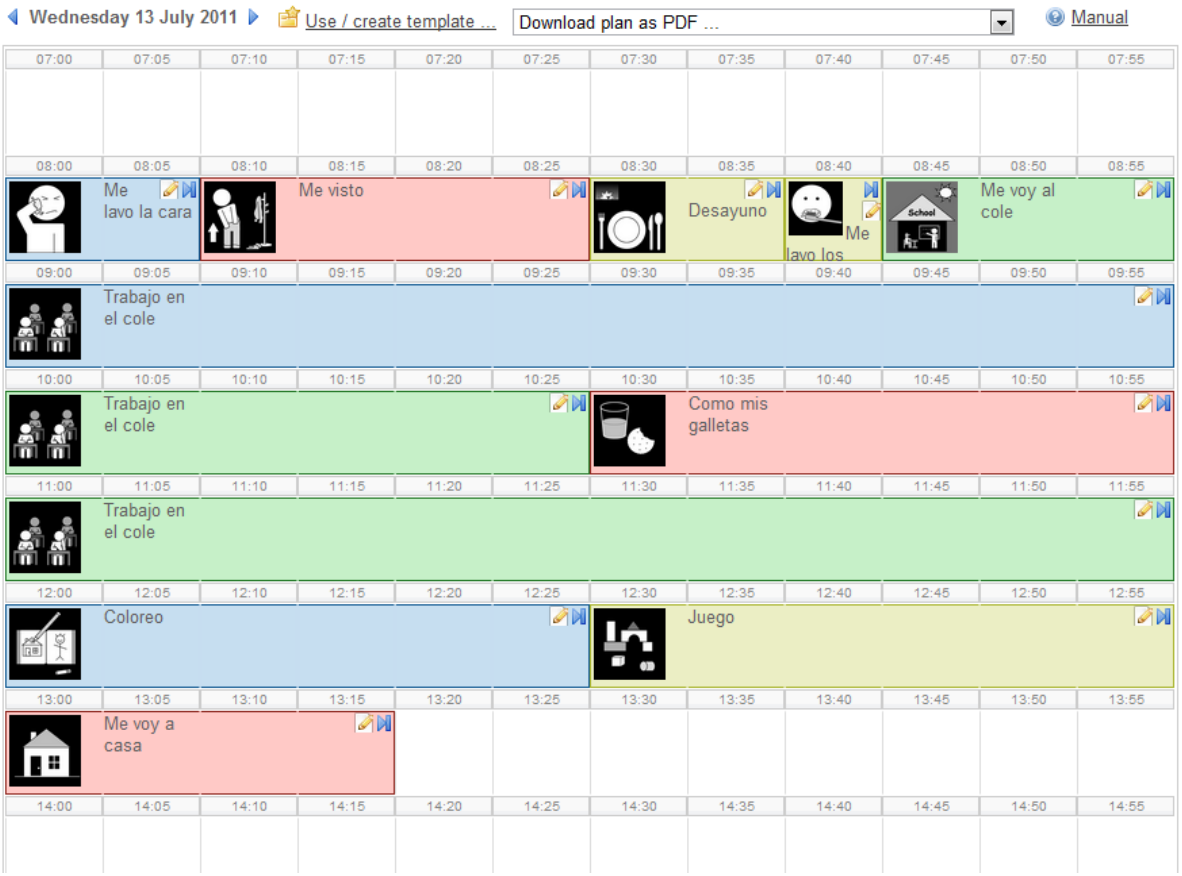
Para mejorar la orientación espacial y temporal y otras capacidades funcionales de los usuarios, realizaremos y utilizaremos materiales de orientación y señalización.

Los materiales de ORIENTACIÓN sitúan a la persona en su entorno concreto y le ayudan a tener un control sobre la situación, lo que repercute de forma positiva en su autoestima. Deberán estar adaptados a las necesidades de los usuarios y serán de especial importancia para personas que tengan algún déficit cognitivo o demencia. Estos materiales son muy efectivos para la realización de rutinas diarias y para ubicar los espacios donde se realizan.

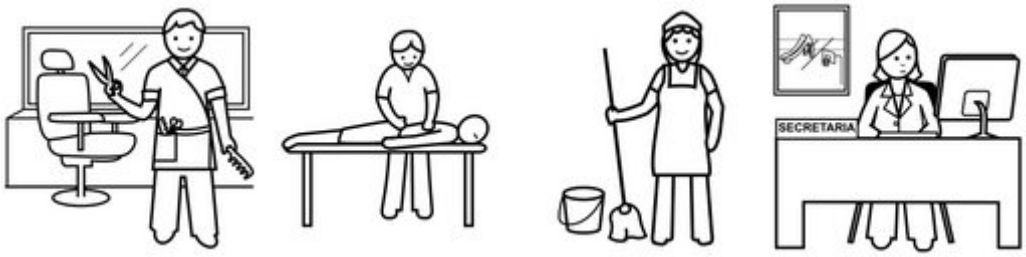
Algunos ejemplos de materiales de orientación que podemos construir:

A) Tableros de Orientación: En ellos se recoge la información básica: fecha, estación del año, lugar, actividades del día, noticias de interés... Estos tableros estarán ubicados en las salas de uso común. Antes de comenzar las actividades recurriremos al tablero para favorecer la orientación espacio-temporal de los residentes.

B) Calendarios: conviene que los símbolos sean de gran tamaño para que se vean con facilidad. Los calendarios permiten orientar al usuario en el día, mes, día de la semana, proximidad de festivos (domingos, verano, Navidades, Semana Sta, Carnavales...)



Carteles Orientativos: indicadores para recordar las diferentes estancias de la residencia, por ejemplo:



Peluquería fisioterapia cuarto de la limpieza administración

En el caso de las demencias las dificultades irán en aumento, por lo que deberemos ir elaborando etiquetas con los nombres de los objetos y colocarlos al lado de ellos.

Deben ser pequeñas, con letra sencilla y que destaque sobre el color del fondo (por ejemplo negro sobre blanco.

Igualmente utilizaremos materiales de simbolización para explicar con fotografías y pictogramas (dibujos sencillos) la realización de las tareas y rutinas. Los materiales de simbolización los podemos utilizar de forma aislada, en el tablero de

comunicación, en el calendario... Todos estos materiales aportan seguridad y control a los residentes.

A la hora de elaborar los materiales de señalización tenemos que tener en cuenta que no hace falta que sean muy detallados, pero sí de fácil comprensión para los usuarios, es adecuado escribir junto con el dibujo lo que representan.

Características específicas de la motivación y el aprendizaje de las personas enfermas dependientes

Entender los motivos que llevan a una persona a comportarse de un modo determinado nos ayudará en la tarea de acompañamiento social y personal.

Conocer las motivaciones interpersonales de cada usuario es fundamental para la organización de las rutinas, la planificación del mantenimiento de los hábitos de la vida diaria y el ajuste de las actividades a sus necesidades. Para ello, resulta imprescindible la observación de su comportamiento en distintas situaciones hasta conocer sus intereses personales, respetando siempre su individualidad.

Por otro lado, podemos motivar a nuestros usuarios hacia las actividades de la institución social si tenemos en cuenta la voluntad propia, los valores, los objetivos y los principios personales de cada uno: ¿qué metas u objetivos se propone esta persona?, ¿qué espera de un taller concreto?, ¿qué cosas le gustaría que ocurrieran en la residencia?, ¿cómo no le gustaría ser tratado por los profesionales que le atienden?, ¿qué prioridades tiene y cómo le gustaría que fuese su vida dentro de la institución?, ¿antes practicaba algún hobby?, ¿qué se le da bien hacer y qué cosas podría enseñar a los compañeros?, etc.

Considerando sus preferencias, los usuarios desarrollarán el sentido de competencia, asumirán un mayor control interno en las acciones que realizan y se sentirán más valiosos y capaces.

Debemos tener siempre presente que es muy importante que las personas dependientes se sientan motivadas para enfrentarse a las actividades del día a día, ya que el hecho de tener voluntad e interés les mueve a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Además, la existencia de una necesidad de cualquier índole hace considerar a la persona importante y conveniente satisfacerla, siendo la motivación el motor que incita a lograr o abandonar algo para conseguir esa satisfacción.

2. Reconocimiento de las características psicológicas de personas dependientes en instituciones

2.1.- Conceptos fundamentales:

La institucionalización conduce a que el individuo deba adaptarse a las nuevas circunstancias y se vea obligado a realizar un reajuste psicológico, de roles y normas. En muchos casos las personas se perciben huérfanas de papeles sociales y de red familiar. Sobre estos aspectos reflexionaremos en este apartado

Ciclo vital.



El ciclo vital es el conjunto de etapas por las que pasa una persona a lo largo de su existencia. Lo "normal" es ir quemando etapas y adaptándonos a las circunstancias que estas etapas nos marcan pero, el ciclo vital de los seres humanos se ve influenciado por factores socioculturales, que requieren la adaptación de la persona a otra forma de vivir o de concebir la vida, distinta de la prevista.

En el caso de enfermedad invalidante a edades no previstas, afectan a la vida laboral y afectiva y modifican el papel social y las relaciones. La discapacidad altera las expectativas y los planes futuros de cualquier persona. Por ejemplo, el caso de una persona que tiene un ACV[31] que le deja secuelas físicas para siempre. Desde entonces padece una hemiplejía izquierda, está impedida y no puede realizar giros en decúbito supino, no consigue incorporarse ni levantarse sin ayuda, necesita apoyo para la realización de las transferencias y depende para desplazarse de la ayuda de otra persona. En cuestión de segundos, esta persona ha visto modificada su existencia por completo.

Existen otros momentos de transición en el ciclo natural de la vida que resultan complejos de entender y difíciles de aceptar, como es el caso de la vejez o ancianidad, que se corresponde con el tiempo de la última etapa de la vida. En ella se produce una crisis vital de desvalimiento: en la mayoría de los casos, con el tiempo, la persona mayor se vuelve dependiente y entonces acontece la crisis más dura de todo el desarrollo humano. Es un periodo de pérdidas casi constantes, tanto en la capacidad funcional, como en la disminución de las relaciones afectivas y otros cambios en la esfera emocional (proximidad del fin de la vida, pérdida de seres queridos, etc.).

[31] Accidente cerbrovascular.

Conducta.



La conducta es la manera con que las personas se comportan en su vida y acciones. Por lo tanto, la palabra puede utilizarse como sinónimo de comportamiento. En este sentido, la conducta se refiere a las acciones de las personas en relación con su entorno o con su mundo de estímulos.

La conducta que muestre la persona dependiente será uno de los elementos clave a observar por el equipo de profesionales, ya que resultará de gran ayuda para determinar el estado de ánimo e incluso de salud del paciente y será un factor fundamental para decidir sobre la asistencia y atención que se le debe prestar.

Hay que analizar no solo la expresión verbal sino también la no verbal de los residentes, es decir, deberá atender tanto a lo que éstos dicen, como lo dicen, con qué palabras, que expresión tienen, qué gestos hacen.....

Es frecuente en las personas dependientes encontrarnos con trastorno de la personalidad por dependencia (TDP). Las personas con TPD tienen un patrón de pensamiento caracterizado por dos supuestos básicos que son los que dan lugar al trastorno de personalidad. Estos supuestos son los siguientes:

1. Se ven a sí mismos como intrínsecamente inadecuados y desvalidos y, por tanto, incapaces de enfrentarse al mundo por sí mismos. El mundo les parece un lugar solitario, frío e incluso peligroso, en el que no creen poder manejarse solos.

2. La solución al problema de ser inadecuado en un mundo horrible consiste en encontrar a alguien que los proteja y cuide. Deciden que vale la pena renunciar a su responsabilidad, necesidades y deseos a cambio de que alguien se haga cargo de ellos. Es decir, su miedo a quedarse solos, sin el apoyo de los demás, es tan intenso que los lleva a renunciar a sus propios deseos, opiniones, valores, etc., y subordinarlos a los de los demás.

Por supuesto, esto tiene consecuencias negativas para estas personas. Al apoyarse en otros para manejar sus problemas y tomar decisiones tienen pocas oportunidades para aprender las habilidades necesarias para ser autónomos. De hecho, algunas de estas personas nunca aprenden las habilidades necesarias para una vida independiente (como asertividad, toma de decisiones, resolución de problemas e interacción social), mientras que otros no reconocen que tienen estas

aptitudes, de modo que no las usan, lo cual perpetúa la dependencia. Además, la idea de volverse más competente puede aterrarles porque temen que si dejan de estar necesitados los abandonarán y no podrán enfrentarse solos al mundo.

A los residentes con TDP, en ocasiones, podemos aplicarles los siguientes adjetivos en lo referente a la conducta:

- Inquieta: sin parar de moverse. Va de un lugar a otro, muy nerviosa.
- Agitada: presentando movimientos rápidos y desordenados, con peligro de hacerse daño o riesgo de dañar a quien esté a su lado.
- Desconfiada: con una actitud suspicaz, mirando de un lado a otro, vigilante. Duda de nuestras intenciones y no colabora ni atiende a nuestras indicaciones.
- Agresiva: manifiesta ataques verbales y su comportamiento hacia los demás es hostil, llegando a provocar conflictos.
- Desinhibida: realiza actos que no se entienden dentro de la normalidad. Por ejemplo, orinar en una papelera, tocamientos sexuales en público, dirigirse a nosotros con excesiva familiaridad, etc.
- Extraña: lleva a cabo conductas extravagantes sin sentido, sin una finalidad concreta; por ejemplo, ir a la pata coja recorriendo una y otra vez el pasillo de un extremo a otro o aparecer con un aspecto estrafalario (un maquillaje desajustado, ropa de otro género, etc.).
- Compulsiva: por ejemplo, fumando un cigarrillo tras otro, abriendo y cerrando la puerta quince veces para asegurarse de que nada malo pasará, contando baldosas al caminar, lavándose las manos hasta desgastarse la piel, etc.
- Fóbica: con muchísimo miedo a realizar alguna acción concreta o a permanecer en algún lugar; un miedo irracional que le impide participar en la vida con normalidad. Así, una persona superada por el miedo a los espacios abiertos no podrá salir de excursión, ni podrá tomar parte en ninguna actividad de ocio a realizar en el exterior y planificada para su integración en la comunidad.

En estos enlaces puedes adquirir pautas de cómo reaccionar frente alguna de estos comportamientos:

http://www.youtube.com/watch?v=ooPpD2h8bMQ
http://www.youtube.com/watch?v=x-ygdeau_5U&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=EAkMyplARpI&feature=related

Es frecuente en estos casos también, llevar una apariencia física descuidada: podemos observar indicadores que saltan a la vista y apuntan que algo dentro de esta persona no marcha de forma adecuada; por ejemplo, cuando se presenta mal vestida (con ropa sucia, mal colocada, no adecuada a la temperatura,…), su higiene abandonada (mal olor, sin afeitar, despeinada,…) o con señales de autolesiones (arañazos o cicatrices en antebrazos,…).

Procesos cognitivos.

Las funciones cognitivas (atención, orientación, percepción, fijación, memoria, etc.) establecen procesos por los que el individuo recibe, almacena y utiliza la información de la realidad y de sí mismo. En consecuencia, si con la edad se producen cambios relacionados con las funciones anteriores, estos afectarán al conjunto de procesos, funciones y capacidades psicológicas fundamentales para nuestra vida.



En el ámbito del funcionamiento intelectual las personas mayores presentan un cierto declive en algunas funciones relacionadas con el rendimiento intelectual, éste no aparece hasta el final de los 60 años y no se trata de una disminución generalizada ya que un importante porcentaje de sujetos no sufre merma alguna.

En cuanto a la memoria, es necesario distinguir dos tipos:

- La memoria primaria, entendida como almacén transitorio de la información, con una capacidad limitada y considerada el centro de la atención consciente.
- a memoria secundaria, que constituye el almacén de información permanente, con una capacidad ilimitada, y a la que se transfiere la información procedente de la memoria primaria.

Con el avance de la edad, la primera modalidad no sufre prácticamente deterioro, excepto en cuanto a la rapidez en la recogida de información. Por el contrario, la capacidad de procesamiento y retención de la memoria secundaria, se puede ver seriamente afectada.

Los problemas relacionados con la memoria provocan en las personas mayores sentimientos de pérdida de control sobre el medio y el propio comportamiento, atribuyéndolos frecuentemente a la edad. Este tipo de atribución provoca, a su vez, un peor resultado en la ejecución de tareas relacionadas con la memoria, con lo cual se produce un círculo vicioso que no siempre es fácil de romper.

TRASTORNOS COGNITIVOS

Olvido Benigno.

Son fallos de memoria de una persona normal (no se considera patológico) cuyas facultades son comparables a las de una población de la misma edad y del mismo nivel cultural. Son olvidos momentáneos, cuya información generalmente es accesible en otro momento.

Delirio-confusión.

Trastorno caracterizado por un comportamiento caótico en un marco angustioso a nivel subjetivo. Ante la incapacidad de respuesta en una situación de crisis, se tiende a generar mayor angustia. Para romper este proceso de feedback será necesario ofrecer al enfermo un marco de contención que reduzca el nivel de angustia.

Demencia.



La demencia se define como un síndrome adquirido de alteración intelectual persistente que compromete la función de múltiples esferas de la actividad mental tales como la memoria, el lenguaje, las habilidades viso espaciales, la emoción o la personalidad y la cognición.

Según la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) as demencias se clasificarían en los siguientes tipos:

- *Demencia tipo Alzheimer* (DTA).

  La fase inicial de la enfermedad puede durar unos dos años y en ella suelen aparecer fallos en la memoria reciente, desinterés, humor deprimido, cambios en la personalidad, episodios leves de desorientación y falta de adaptación a situaciones nuevas. En esta fase es difícil de diagnosticar la DTA.

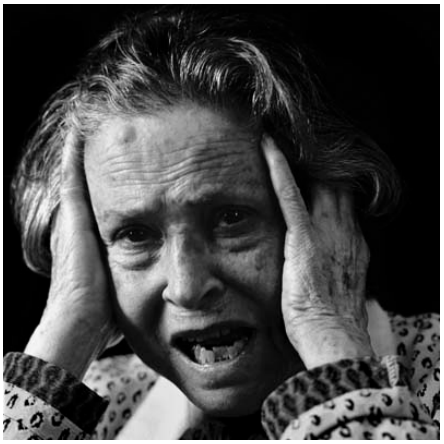
  La fase intermedia puede desarrollarse durante 3-5 años. El detrimento de la memoria es más comprometido y afecta no solo a la memoria reciente sino también a la remota. Emergen alteraciones del lenguaje, la escritura, la lectura, el cálculo, apraxias[32] y agnosias[33]. Muestra dificultad con el aseo, el vestir o la comida. Pueden aparecer síntomas psicóticos. En esta fase el paciente tiene dificultad para mantener sus relaciones sociales y es incapaz de mantener una discusión sobre un problema.

[32] s un trastorno neurológico caracterizado por la pérdida de la capacidad de llevar a cabo movimientos de propósito, aprendidos y familiares, a pesar de tener la capacidad física (tono muscular y coordinación) y el deseo de realizarlos. Es decir, existe una disociación entre la idea (el paciente sabe lo que quiere hacer) y la ejecución motora (carece del control de acción)

[33] es la interrupción en la capacidad para reconocer estímulos previamente aprendidos o de aprender nuevos estímulos sin haber deficiencia en la alteración de la percepción, lenguaje o intelecto

En la fase terminal (demencia grave) el enfermo es incapaz de andar, se inmoviliza, se hace incontinente y no puede ejecutar ninguna actividad de la vida diaria. El lenguaje se hace ininteligible o presenta mutismo. A veces se produce disfagia y hay riesgos de neumonías, deshidratación, malnutrición y úlceras por presión. Los enfermos pueden permanecer en cama y suelen fallecer de una neumonía u otra infección intercurrente.

- *Demencia vascular.*



La expresión demencia vascular hace referencia al deterioro cognitivo global originado a raíz de la existencia de una enfermedad vascular cerebral de tipo isquémico o hemorrágico, siendo necesario una unión temporal entre ambas situaciones.

Los principales factores de riesgo para el desarrollo de patología vascular cerebral son bien conocidos, como la edad avanzada, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, las dislipemias como la hipeolemia, el tabaquismo, el alcohol y la fibrilación articular. El control adecuado de estos factores debería conllevar una reducción en la incidencia y la prevalencia de la demencia vascular.

- *Demencia debida a otras enfermedades médicas*.

  Es el tipo de demencia ocasionada por patologías como puede ser la enfermedad por HIV, el traumatismo craneal, la enfermedad de Parkinson, la a enfermedad de Huntington, la enfermedad de Pick, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob entre otras.

- *Demencia persistente inducida por sustancias.*

  La demencia persistente inducida por sustancias no se diagnostica si los síntomas se presentan a continuación de una intoxicación o abstinencia de sustancias, o si aparecen exclusivamente en el transcurso de un delirium.

- *Demencia debida a múltiples etiologías*

  Esta categoría de demencia se incluye para llamar la atención sobre la pluralidad de causas de demencia.)

- *Demencia no especificada.*

  Debe usarse para diagnosticar una demencia que no cumple con los criterios diagnósticos para ninguno de los tipos anteriormente mencionados.

Motivación.

La motivación deriva del latín motus, que significa «movido», o de motio, que significa «movimiento». La motivación puede definirse el impulso que inicia, guía y mantiene el comportamiento, hasta alcanzar la meta u objetivo deseado. Su carácter es selectivo y lleva a la persona a desencadenar una conducta determinada.

La motivación vendrá siempre determinada por las necesidades que presente el individuo y las actuaciones que está dispuesto a llevar a cabo para lograr su satisfacción. De esta forma, cuanto más imperiosa sea la necesidad, mayor será el empeño que el individuo pondrá en satisfacerla. Así, necesidades como respirar, alimentarse o dormir, provocarán en el individuo una mayor urgencia en su satisfacción que otras como la de la autorrealización o la estética.

La ordenación de las necesidades fue establecida por Maslow en el siglo XX y se ilustran en la llamada Pirámide de Maslow:



Así, necesidades fisiológicas (respirar, alimentarse o dormir), provocarán en el individuo una mayor urgencia en su satisfacción que otras como la de la autorrealización. Por lo tanto, las de la base serán el motor más potente de la motivación y a medida que ascendemos en la pirámide, las intensidad de las necesidades cae y de la misma manera la motivación que generan.

Emoción, alteraciones.

Las emociones son experiencias muy complejas y para expresarlas utilizamos una gran variedad de términos, además de gestos y actitudes. De hecho, podemos utilizar todas las palabras del diccionario para expresar emociones distintas y, por tanto, es imposible hacer una descripción y clasificación de todas las emociones que podemos experimentar. Sin embargo, el vocabulario usual para describir las emociones es mucho más reducido y ello permite que las personas de un mismo entorno cultural puedan compartirlas. En la siguiente tabla se muestran algunas, tanto en sus vertientes positivas como negativas.

Emociones positivas		**Emociones negativas**	
Me siento ...	Siento...	Me siento ...	Siento ...
Bien	Bienestar	Mal	Malestar
Feliz	Felicidad	Desgraciado	Desgracia
Sano	Salud	Enfermo	Enfermedad
Alegre	Alegría	Triste	Tristeza
Fuerte	Fortaleza	Débil	Debilidad
Acompañado	Compañía	Solo	Soledad
etc.	Etc.	etc.	Etc.

Una correcta gestión de las emociones puede transformar una persona que sufre y se lamenta en una persona integrada que goza de la vida.

La forma de sentir y de expresar las emociones está igualmente relacionada con el aprendizaje que una persona haya recibido, con factores sociales y con los rasgos de su personalidad, influyendo también las habilidades de comunicación no verbal que posea.

Aprender a decodificar el lenguaje emotivo de cada usuario y reconocer el estado afectivo que presenta a través de la observación de las señales emocionales que transmite, podrá ayudarnos a detectar la presencia de trastornos emocionales como la depresión o ansiedad, de frecuente aparición en las personas institucionalizada.

Los trastornos emocionales más habituales en las personas institucionalizadas son:

- Trastornos depresivos.
- Trastornos bipolares
- Tristeza patológica.
- Alegría patológica.
- Ansiedad y angustia patológicas

TRASTORNOS DEPRESIVOS.

En personas institucionalizadas, la depresión, con frecuencia no es reconocida, diagnosticada ni tratada adecuadamente, debido a que en muchas ocasiones los síntomas depresivos son interpretados como algo normal asociado a la dependencia.



Los síntomas de la depresión son:

- Disminución de la vitalidad. Sensación de pérdida de fuerza, energía y/o cansancio.
- Disminución o aumento del sueño.
- Disminución o aumento del apetito, de manera que se produce un cambio de peso.
- Motilidad y expresividad lenta y escalas.
- Pérdida de la ilusión y el interés incluso por las cosas que antes le motivaban.
- Sentimiento fuerte de tristeza, de vacío, de insensibilidad antes cosas que anteriormente le importaban.
- Falta de capacidad para disfrutar de las cosas, incluso de aquellas que siempre le proporcionaban placer.
- Pesimismo, desesperanza.
- Falta de confianza en uno mismo.
- Indecisión e inseguridad ante las tareas.
- Intentan ocultar su depresión.
- Se muestran irritables y de mal humor.
- Se muestran agitados y ansiosos.
- Aislamiento social.
- Disminución del cuidado de uno mismo.
- Pensamientos sobre su muerte y/o suicidio.

Las razones por las que se deprime una persona mayor son:

- Factores biológicos (neurotransmisores, enfermedades como el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, consumo excesivo de medicamentos, etc.).
- Factores psicológicos: formas ineficaces de enfrentarse a los problemas (estrategias de afrontamiento, estilos de control, estilos de pensamiento, etc.), baja autoestima, sentimiento de inseguridad, sensación de impotencia, ausencia o escasez de refuerzos positivos, sensación de declive y pérdida, sentimiento de inutilidad y de indefensión aprendida.
- Factores sociales: recursos disponibles (apoyo social emocional e instrumental), pérdidas sufridas, pobreza, vivienda inadecuada.

También influyen de forma importante sobre la depresión:

- Hábitos de salud que tenga la persona dado que, por ejemplo, hábitos alimenticios inadecuados, fumar, beber alcohol o una falta de ejercicio físico regular pueden causar depresión directamente (por sus efectos sobre el sistema nervioso central) o indirectamente (provocando discapacidad).
- Mayor frecuencia de situaciones adversas o factores sociales adversos. Sucesos vitales negativos (por ejemplo., muerte o enfermedad de un familiar o ser querido).
- Viudedad.
- Problemas de sueño.
- Discapacidad.
- Dolor crónico.
- Historia de otros problemas depresivos.

TRASTORNOS BIPOLARES



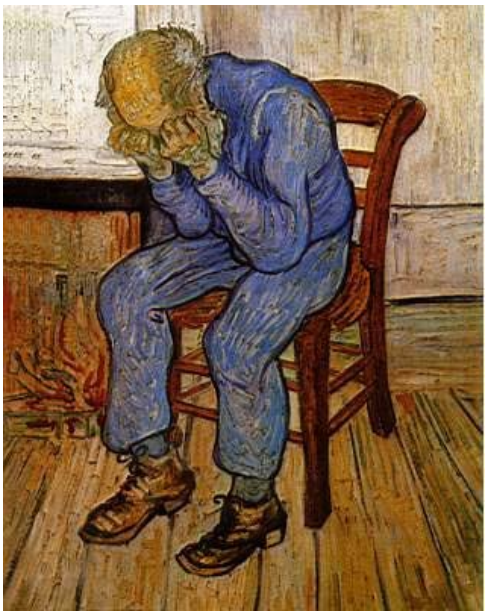
Es un trastorno afectivo crónico de curso cíclico con tendencia a la recurrencia de episodios depresivos y maníacos (de excitabilidad) con intervalos asintomáticos entre los episodios.

El trastorno bipolar es una enfermedad cuyo inicio ocurre más frecuentemente en edades tempranas de la vida (20-30 años) pero el aumento de la esperanza de vida ha provocado un incremento del número de pacientes bipolares en edad avanzada.

TRISTEZA PATOLÓGICA.

La tristeza normal y patológica, respectivamente, son la expresión de la afectación de dos fenómenos psíquicos muy distintos: el humor o estado de ánimo y los sentimientos. Hablamos de tristeza normal cuando ésta es meramente una estimulación del sentimiento y de tristeza patológica cuando ésta es la expresión de una alteración del estado de ánimo.

La tristeza es un sentimiento que se experimenta ante una gran diversidad de situaciones cotidianas desagradables o adversas, cuyo común denominador es, por lo general, la pérdida de algo más o menos importante. Se trata, por lo tanto, de una experiencia psicológica corriente, coherente con lo que la desencadena y con una intensidad y duración adecuados a la situación desencadenante. La tristeza patológica, que no siempre se puede diferenciar nítidamente de la normal, se caracteriza por aparecer sin motivo fácilmente identificable, y cuando éste existe, no guarda proporción con el desencadenante, y afecta de manera importante al funcionamiento global.



ALEGRÍA PATOLÓGICA.

La persona experimenta una energía y capacidad extremas. Su talante puede resultar omnipotente, con una autoestima sobreelevada y una alegría exagerada que puede tornarse fácilmente en agresividad o ironía si se le contradice. Puede mostrarse eufórica hiperactiva, más habladora de lo habitual y con la sensación de que su pensamiento está acelerado. Su comportamiento social es a menudo desinhibido, pudiendo conducir a realizar grandes gastos económicos, imprudencias e indiscreciones sexuales, etc.

ANSIEDAD Y ANGUSTIA PATOLÓGICAS

La angustia en este grado supone un estado emocional en el cual la persona se siente muy tensa, inquieta, con la impresión de inseguridad y el temor de que va a sucederle algo. Atemorizada y alarmada de manera desagradable, puede experimentar corporalmente:

- Opresión torácica.
- Constricción de la garganta.
- Debilidad en las piernas.
- Disnea[34]
- Palpitaciones.

[34] Dificultad respiratoria.

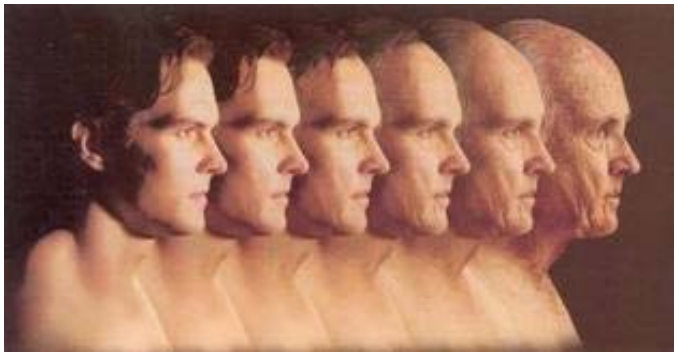
- Sensación de vértigo.
- Etc.

En los cuadros más graves puede aparecer la sensación de pánico o crisis de angustia. Los ataques pueden presentarse cuando la persona dependiente:

- Se encuentra en estado de ansiedad.
- Padece esquizofrenia (junto con otros síntomas como las alucinaciones y los delirios).
- Manifiesta un cuadro depresivo (en ocasiones se produce el efecto inverso de la inhibición y la persona en estado depresivo manifiesta una importante inquietud).
- En enfermedades somáticas, como trastornos hormonales y metabólicos, hipertiroidismo o hipoglucemia, entre otras.

2.2.- Proceso de envejecimiento.

Definir qué es el envejecimiento no es fácil.



El paso del tiempo produce cambios físicos, metabólicos, mentales y fisiológicos continuos, irreversibles e inevitables, de manera que al final llega la muerte. Estos cambios inevitables se consideran "envejecimiento fisiológico"

Al envejecimiento fisiológico hay que añadir las alteraciones que ocasionan el estilo de vida, el medio ambiente y las enfermedades padecidas, los que dan lugar al denominado "envejecimiento patológico", diferente para cada persona.

El resultado de ambos procesos dan lugar a la edad biológica o funcional de un individuo que no tiene por qué coincidir con la edad cronológica. Cualquiera puede citar a personas que representan una edad diferente de la suya, a veces más viejos, a veces más jóvenes

Enfermedad y convalecencia: cambios bio-psico-sociales.

Es importante que diferenciemos entre vejez y enfermedad, con la edad disminuye la capacidad orgánica y funcional así como la capacidad del sistema inmunitario pero:

"Vejez no es sinónimo de enfermedad"

Cierto que durante el proceso de envejecimiento se producen una serie de cambios que afectan tanto al aspecto biológico como al psicológico de la persona. Pero, además, también se produce una importante transformación en el papel social que hasta entonces ha desarrollado esa persona.

CAMBIOS BIOLÓGICOS RELACIONADOS CON LA EDAD

Sistemas sensoriales

a.) Visión
- Disminuye el tamaño de la pupila.
- Menor transparencia y mayor espesor del cristalino, lo que provoca que llegue menor cantidad de luz a la retina y empeore la visión lejana.
- Disminuye la agudeza visual y la capacidad para discriminar colores.

b.) Audición
- Menor agudeza para las frecuencias altas (tonos agudos), lo que deteriora la capacidad para discriminar palabras y comprender conversaciones normales. Esta es la causa de que una persona mayor tenga más problemas en oír las voces femeninas, ya que suelen ser más agudas.

c.) Gusto y olfato
- Disminuye la sensibilidad para discriminar los sabores salados, dulces y ácidos, debido al deterioro de las papilas gustativas.
- Pérdida de capacidad para discriminar los olores de los alimentos.
- La combinación de esos dos factores es una de las causas por la que la mayoría de los usuarios se quejan de las comidas servidas en las instituciones de atención sociosanitaria.

d.) Tacto

La piel es el órgano relacionado con la capacidad sensorial del tacto. Los cambios que se producen en la piel pueden observarse a simple vista, como son:

- Aparición de arrugas.
- Manchas.
- Flaccidez.
- Sequedad.

Todos esos cambios se producen como consecuencia de transformaciones internas, como son la disminución en la producción de colágeno y la pérdida de grasa subcutánea y masa muscular.

Pero también pueden ser originados por deficiencias en la alimentación, por posibles enfermedades o por una excesiva exposición al sol sin la suficiente hidratación aplicada por vía tópica (cremas).

Sistemas orgánicos

a.) Estructura muscular

Se produce una importante pérdida de masa muscular y una atrofia de las fibras musculares, que disminuyen en peso, número y diámetro. Consecuentemente, estos cambios traen consigo el deterioro de la fuerza muscular.

b.) Sistema esquelético



- La masa esquelética disminuye, pues los huesos se tornan más porosos (menos
- densidad del hueso) y quebradizos.
- Debido al proceso de desmineralización, los huesos también se vuelven más frágiles y, por lo tanto, más vulnerables a la fractura.
- Estos cambios afectan en mayor medida a las mujeres, debido a las siguientes causas: mayor pérdida de calcio, factores genéticos, factores hormonales (menopausia), inactividad física, consumo de tabaco y alcohol, malos hábitos de alimentación, etc.

c.) Articulaciones

- Se tornan menos eficientes al reducirse la flexibilidad. Se produce mayor rigidez articular debida a la degeneración de los cartílagos, los tendones y los ligamentos, que son las tres estructuras que componen las articulaciones. La principal consecuencia es el dolor.

Sistema cardiovascular

a.) El corazón:

Aumento del ventrículo izquierdo, mayor cantidad de grasa acumulada envolvente, alteraciones del colágeno, que provocan un endurecimiento de las fibras musculares y una pérdida de la capacidad de contracción, entre otros cambios.

b.) Los vasos sanguíneos se estrechan y pierden elasticidad, al aumentar de grosor y acumular lípidos en las arterias (arterioesclerosis).

El estrechamiento y la pérdida de elasticidad dificultan el paso de la sangre.



c.) Las válvulas cardiacas se vuelven más gruesas y menos flexibles, es decir, necesitan más tiempo para cerrarse.

Todo estos cambios conducen a un aporte menor de sangre oxigenada y esto, a su vez, se convierte en una causa importante por la que disminuye la fuerza y la resistencia física general.

Sistema respiratorio

Su rendimiento queda mermado debido a diversos factores, entre los que se encuentran la atrofia y el debilitamiento de los músculos intercostales, los cambios esqueléticos (caja torácica y columna) y el deterioro del tejido pulmonar (bronquios).

Todo ello produce una disminución del contenido de oxígeno en sangre, que se reduce entre un10% y un15%, y en la aparición de una enfermedad respiratoria, el enfisema, muy común en personas de edad avanzada.

Sistema excretor

El riñón tiene una menor capacidad para eliminar los productos de desecho. Por esta razón, se hace necesario para el organismo aumentar la frecuencia miccional.

El deterioro del sistema excretor también hace frecuentes los episodios de incontinencia.

Sistema digestivo

En general, todos los cambios se traducen en una digestión dificultosa y en la reducción del metabolismo de ciertos nutrientes en el estómago y el intestino delgado.

Los cambios más frecuentes son:

- Pérdida de piezas dentales, que originan un problema considerable en la digestión de los alimentos, para la cual es importante una buena masticación.
- Disminución de los movimientos esofágicos (contracción/relajación), cuya función es facilitar la deglución.
- Reducción de la capacidad para secretar enzimas digestivas, lo que también dificulta la digestión.
- Atrofia de la mucosa gastrointestinal, por lo que la absorción de nutrientes es menor.
- Disminución del tono muscular y el peristaltismo del intestino, que producen menor masa y frecuencia en la eliminación de sólidos y, por tanto, estreñimiento.
- Vesícula e hígado: en las personas mayores se produce una mayor incidencia de cálculos biliares y un menor tamaño y eficiencia del hígado.

CAMBIOS SOCIALES Y PSICOLÓGICOS RELACIONADOS CON LA EDAD

Cuando hablamos de roles sociales nos referimos al conjunto de funciones, normas, comportamientos y derechos definidos social y culturalmente, que se esperan que una persona cumpla o ejerza de acuerdo a su estatus social, adquirido o atribuido.

Así pues, el rol es la forma en que un estatus concreto tiene que ser aceptado y desempeñado por el titular.

Con el paso de los años, esos roles van cambiando y, al llegar el envejecimiento, la sociedad obliga al individuo a abandonar algunos de esos roles que ha desempeñado durante toda su vida.

Esta nueva situación conlleva una serie de cambios sociales y psicológicos en el individuo.

Cambios sociales

Existen numerosas teorías que intentan explicar los cambios psicosociales que se producen con el envejecimiento y el origen de esos cambios.

Las principales teorías que explican el fundamento de esos cambios, se desarrollan en la siguiente tabla :

	Teoría de la desvinculación	Teoría de la actividad	Teoría de la continuidad
Autor	Cumming y Henry (1961)	Tartler (1961)	Atchley (1971)
Fundamentación	Lo natural es la desvinculación del entorno. Envejecimiento satisfactorio cuando la sociedad ayuda al individuo a abandonar sus roles sociales y obligaciones.	A mayor actividad, mayor satisfacción. La sociedad es responsable de la pérdida de actividad (p.ej., jubilación).	Continuidad en los estilos de vida de otras etapas. Se mantienen los mismos estilos, pero acentuados. Requisito para un envejecimiento satisfactorio: permitir esa continuidad.
Aspectos que no considera	Importancia de factores endógenos (de dentro de la persona o de su medio). Desvinculación selectiva (solo de algunos aspectos). Desvinculación transitoria en determinados periodos.	No todos poseen la capacidad suficiente para reorganizar su actividad tras la jubilación. La falta de refuerzos positivos de la sociedad conlleva desesperanza.	

Comparando todas esas teorías se llega a varias conclusiones:

- La disminución o ausencia de actividad social no aparece de forma repentina en los mayores. Lo habitual es que esa actividad se vaya reduciendo paulatinamente con el paso del tiempo.
- Al reducirse la frecuencia de las relaciones sociales, se refuerza su valor y se hacen más gratificantes, dedicando más tiempo a su mantenimiento.
- Se observa que la calidad de la interacción resulta ser más determinante que la cantidad.

Cambios psicológicos

Para explicar los cambios psicológicos que puede sufrir el individuo al llegar a la vejez, nos vamos a basar en las dos teorías principales elaboradas sobre esta circunstancia: la teoría de Erikson y la de Peck.

Los fundamentos de ambas se desarrollan en la siguiente tabla:.

	Teoría de Erikson (integración vs. desesperación)	Teoría de Peck
Fundamentación	El ser humano pasa por ocho crisis, que se corresponden con los cambios de etapa vital. En la octava etapa se produce la necesidad de aceptar el modo de vida que el sujeto ha seguido (integración). Si no se produce esa aceptación, se llega a la desesperación.	El ser humano pasa por tres crisis, que se corresponden con los cambios de etapa vital. Es necesario resolver las tres crisis para envejecer de forma saludable y extender su identidad más allá de su trabajo, bienestar físico y existencia propia.

Incidencias en la calidad de vida.

De los estudios realizados sobre los trastornos del estado de ánimo, la ansiedad y la autoestima en personas mayores, se puede destacar que un 15-25% de la población general padece algún trastorno de carácter psicopatológico.

Otra de las conclusiones del estudio es que existe una mayor comorbilidad, con deterioro cognoscitivo, suicidio, incremento de las tasas de mortalidad, otros trastornos mentales y, en definitiva, un empobrecimiento de la calidad de vida.

En algunos de estos estudios queda reflejado que la presencia de depresión en los mayores favorece la aparición de otros efectos:

- Descenso de la calidad de vida.
- Aumento de las enfermedades físicas.
- Disminución de la esperanza de vida.
- Incremento del riesgo de sufrir una muerte prematura por la aparición de enfermedades somáticas.
- No aceptación de la nueva situación de dependencia. Esta quizás sea la consecuencia más grave.

La adaptación a la circunstancia vital de la dependencia varía en función de numerosos factores, entre ellos:

- Los recursos psicológicos de cada individuo.
- Las causas de la dependencia.
- El pronóstico de la dependencia.
- El entorno social y familiar.
- El apoyo recibido.

En líneas generales, resultará menos complicada la adaptación para las personas mayores que mantengan su residencia que en las que ingresen en una institución. Pero, como contrapartida, estas últimas renuncian a esa otra «autonomía» psicológica que supone el poder de decisión sobre lo relativo a su cuidado personal (como el día o la hora de baño, de acostarse o de ir a comer).

En este punto resalta la importancia de las necesidades especiales de atención y de apoyo integral para las personas mayores, pero no centradas exclusivamente en la satisfacción de las necesidades básicas (cuidado de su higiene y de su alimentación), que sin duda son fundamentales y las primeras que se deben atender.

Se trata de considerar que, además de ellas, el ser humano tiene otras necesidades, como la necesidad social, de autoestima y de realización, que deben de atenderse con el mismo cuidado que las primeras para alcanzar una calidad de vida aceptable.

De ahí la importancia de cuidar esas pequeñas pero importantes «acciones» que merman al sujeto institucionalizado de la expectativa de control sobre su propia vida (la posibilidad de elección de la ropa, cómo arreglarse, el lugar donde permanecer) y que menoscaban la autoeficacia percibida sobre sus capacidades reales, afectando esto a su motivación y a su conducta.

Así pues, la dependencia no solo hace referencia a las capacidades de la persona. También interfiere en su creencia sobre sus propias capacidades, determinando

la consecución del rendimiento deseado según su comportamiento basado en estas expectativas. Nos estamos refiriendo a la autoeficacia, que consiste en tener fe en uno mismo.

La autoeficacia es un estado psicológico en el que el sujeto se juzga capaz de ejecutar una conducta en unas determinadas circunstancias y a un determinado nivel de dificultad.

Por el contrario, la percepción de uno mismo como un sujeto «no capaz» fomenta la desesperanza o indefensión, que es un sentimiento estrechamente ligado a la depresión.

La indefensión aprendida es aquella condición psicológica en la que una persona aprende a creer que está indefensa, que no tiene ningún control sobre la situación en la que se encuentra y que cualquier cosa que haga para salir de ella será inútil.

El resultado de la indefensión es una conducta pasiva frente a cualquier situación no placentera o perjudicial, incluso cuando es posible realmente cambiar esas circunstancias.

El problema radica en que ese tipo de conducta se extrapola a otras situaciones vitales, de forma que la persona aprende a pensar que haga lo que haga, los resultados no dependen de su esfuerzo o conducta, sino de otros factores ajenos, como la suerte, el azar o el destino.

Las conductas de apoyo favorecerán la autoeficacia y, por tanto, la autoestima.

Así pues, el ambiente en el que se desenvuelvan las personas mayores adquiere gran relevancia para favorecer la estimulación y la actitud activa Para favorecer el autoconcepto positivo y su desarrollo es recomendable:

- Fomentar la consecución de logros en pequeñas tareas. Por ejemplo, logros en su cuidado personal, en la actividad intelectual o en otras actividades relacionadas.
- Aplicar refuerzos positivos tras la realización de alguna tarea positiva, como puede ser felicitarle por lo que ha hecho y comentarlo en su presencia delante de otros compañeros.

Una persona con un alto grado de bienestar psicológico sentirá mayor autoeficacia y, por tanto, mayor percepción subjetiva positiva sobre su situación. De ese modo, ampliará su perspectiva de vida autónoma. Como conclusión podemos decir que la adaptación de un sujeto a su medio habitual, su promoción en la toma de decisiones en asuntos cotidianos y la estimulación adecuada en la ejecución de sus tareas básicas, aumentarán su capacidad para desempeñar actividades cotidianas esenciales y, por tanto, retrasarán la dependencia o el aumento de ella, en el caso de existir.

El bienestar subjetivo, la autoestima y la capacidad de ser independiente funcionalmente van estrechamente ligados.

El miedo a perder esta capacidad de «valerse por sí mismos» es el más frecuente, tal como se recoge en los datos del IMSERSO (1995) y, por ende, el principal valor de esta población es mantener su «estilo de vida propio»

Evolución del entorno socioafectivo y de la sexualidad de la persona mayor.

EVOLUCIÓN DEL ENTORNO SOCIOAFECTIVO



Como ya hemos visto en un punto anterior, el entorno social adquiere gran importancia para el individuo.

Pero el descenso de los contactos sociales que conlleva el envejecimiento no equivale a un descenso en el apoyo recibido; así como tampoco un mayor número de interacciones trae como obligada consecuencia un aumento en la percepción subjetiva de apoyo.

Los conceptos de apoyo social, entorno socioafectivo y red social se comprenden de forma

intuitiva. Pero la dificultad aparece a la hora de delimitar y especificar dichos conceptos.

Desde hace décadas se estudian las repercusiones de los lazos sociales en la salud del individuo y se ha llegado a la siguiente conclusión: las consecuencias del estrés serán menores y la resistencia a la enfermedad mayor, si existen relaciones sociales de apoyo.

El apoyo que cualquier sujeto puede recibir desde su entorno puede ser de varios tipos:

- Apoyo instrumental

Se refiere al suministro de bienes materiales y servicios que puedan ayudar en la solución de problemas prácticos.

- Apoyo emocional

Se relaciona con la información que recibe el sujeto de ser respetado, amado, valorado e integrado en una red social.

- Apoyo de estima

Consiste en disponer de alguien con quien poder comentar los problemas propios, el poder comunicar las contrariedades refuerza la autoestima; tal vez, porque al hacerlo se produce el sentimiento de ser valorados y aceptados por otra persona. Esto tiene un efecto positivo en las posibles amenazas percibidas en situaciones de estrés y la potenciación de nuestros propios recursos para hacer frente a esos problemas.

- Apoyo informativo

Se trata de facilitar la información necesaria que ayudará a resolver un determinado problema, para disminuir el sentimiento de confusión e impotencia, e incrementar la sensación de control sobre la situación, aumentando así el bienestar psicológico.

• Compañía social

La actividad social, sobre todo la de carácter lúdico, es un generador de estado de ánimo positivo. Las actividades lúdicas, formativas, deportivas, etc., son un fin en sí mismas que debemos alentar y apoyar, tanto en los hombres como en las mujeres. Todas ellas inciden positivamente tanto en la esfera psíquica de la persona como en la física. Debemos reconocer que la persona no tiene limitaciones.

Al llegar a la vejez, la red social a la que siempre había pertenecido el individuo se transforma:

Los lazos familiares son uno de los principales vínculos sociales que se tienen:

- La pareja y los hijos suelen ser el principal apoyo de la persona.
- En las mujeres, sobre todo, también se mantienen las relaciones vecinales de toda la vida.
- Aparece el rol de abuelo/a. Lo que ocurre es que con el tiempo esta relación va cambiando: de ser una fuente de ayuda, pasa a ser una carga familiar (es en este momento cuando la familia se plantea el ingreso en una institución).
- Se pierden vínculos, como los compañeros de trabajo; también fallecen amistades de toda la vida, vecinos, familiares… pero se pueden ganar otros muchos dependiendo de la actitud que adopte la persona ante su nueva situación.

A su vez, esa red social se contrae por causas muy diversas, tales como:

- Mortandad de los miembros.
- Falta de nuevas relaciones significativas.
- Mantener los actuales resulta cada vez más difícil (dificultad para desplazarse, por ejemplo).
- • El ingreso en una institución puede provocar alteraciones en la conducta (ideas paranoides, por ejemplo), que dificultan las relaciones.
- La pérdida de capacidades sensoriales puede disminuir la capacidad de relación (sordera, dificultad en la visión…).
- Por la pérdida de las relaciones laborales.

La disminución de la red social trae como consecuencia que las relaciones familiares adquieran una mayor relevancia, ya que serán las que perduren en el tiempo.

La pérdida de relaciones sociales conlleva también la pérdida de roles, de recuerdos, incluso de la propia identidad. Con la desaparición de las personas significativas también desaparecen los anclajes de la historia personal.

Sea como sea, la motivación de la persona mayor para establecer nuevas relaciones disminuye y lo hace en la misma proporción que la autonomía y la autoestima, lo que suele llevarla a aislarse y refugiarse en una soledad en la que se siente segura. De ahí la importancia de un programa de intervención adecuado para fomentar la participación en grupos, favorecer el dinamismo de las relaciones entre usuarios y aumentar la actividad social

EVOLUCIÓN DE LA SEXUALIDAD DE LA PERSONA MAYOR



Comprensiblemente, si el entorno socioafectivo se ve afectado negativamente por la edad y el ingreso en una institución, también se verá afectada la posibilidad de establecer nuevas relaciones íntimas.

La primera consideración que debemos hacer sobre este tema es que la sociedad margina a los mayores y les trata como seres asexuados, cuando la sexualidad es una más de las acciones propias del ser humano.

La sexualidad es una de las necesidades básicas de la persona, en concreto, la tercera después de la necesidad de alimentación y la de seguridad.

Normalmente, la sexualidad queda enmarcada dentro de una relación de pareja o de amistad. Pero en la conducta sexual existen muchas diferencias individuales en las que influyen factores bio-psico-sociales, igual que veíamos que ocurría en otros aspectos de la vida.

La diferencia con ellos es que la sexualidad es una relación bidireccional, porque una vida sexual activa influye y favorece positivamente los aspectos fisiológicos y psicológicos de la persona.

La vivencia sexual de los mayores está condicionada por influencias sociales relacionadas con las creencias religiosas, la educación recibida y por la actitud de los otras personas (familia, amigos, compañeros) hacia este aspecto.

La sexualidad en la vejez persigue los mismos objetivos que en otra etapa de la vida: placer del contacto corporal, comunicación, dignidad, aceptación sin paternalismos y la seguridad emocional que da sentirse querido

La conducta sexual viene motivada originariamente por tres aspectos: la reproducción, el deseo de placer y la comunicación afectiva. La actividad sexual favorece la intimidad y la autoestima de ambos partícipes, pero no implica necesariamente la práctica exclusiva del coito.



Nuestros mayores recibieron en su juventud una educación sexual deficitaria y, en la actualidad, continúan desinformados (guardan creencias negativas al respecto) y temen pedir información.

Cuando, en el mejor de los casos, se atreven a pedirla, lamentablemente se suelen encontrar con respuestas evasivas, incluso de los propios profesionales.

Los mayores que mantienen el deseo o la actividad sexual normalizada se suelen sentir avergonzados por los estereotipos sociales que plantean que la sexualidad y la vejez son situaciones incompatibles.

Nuestros objetivos como profesionales irán encaminados a los siguientes aspectos:

- Promover la expresión en los mayores de su «problemática sexual» y erradicar las falsas creencias.
- Dar a conocer los cambios que se esperan normalmente con el envejecimiento corporal, para que cada uno se adapte a la nueva situación y optimice sus posibilidades.
- Favorecer que las personas mayores tengan unos vínculos afectivos estables y, si lo desean, también íntimos.

En las siguientes tablas se recogen los cambios en la conducta sexual asociados con los cambios funcionales propios del envejecimiento

Cambios en la conducta	Cambios funcionales
Disminución del deseo sexual, fuertemente condicionado por la apariencia física y la autoestima.	Disminución del tamaño de ovarios, trompas y útero y atrofia de la mucosa de endometrio, cuello uterino y vagina.
La prevalente incontinencia urinaria inhibe el deseo de contacto íntimo, por prejuicios adquiridos.	Tras la menopausia, reducción de los niveles estrogénicos y androgénicos.
Se mantiene la capacidad multiorgásmica, pero de menor intensidad.	Enlentecimiento de la fase de excitación sexual.
	Menor y más lenta secreción de moco cervical, provocando dificultad en la penetración y, posiblemente, dolor. La vagina se hace más vulnerable a posibles lesiones por roce.
	Menor grado de acidez del medio vaginal, aumentando el riesgo de infecciones.
	Vagina más corta y menos elástica.
	Menor intumescencia del clítoris y de la plataforma vaginal.
	Disminución en frecuencia e intensidad de las contracciones orgásmicas.
	Menor rubor cutáneo y más limitado, tensión muscular en el coito y tensión mamaria.
	Aceleración del descenso postcoital.

Cambios en la conducta	Cambios funcionales
Menor deseo sexual.	Reducción de los niveles de testosterona.
Cambios en la respuesta sexual.	Menor sensibilidad peneana.
Coitos de mayor duración.	Disminución del número de erecciones nocturnas involuntarias.
Necesidad de caricias directas en los genitales.	Enlentecimiento de la erección. Es necesario más tiempo (hasta 10 minutos) y mayor estimulación para alcanzar el orgasmo, siendo éste de menor duración.
Disfrute del coito sin necesidad de llegar a la eyaculación.	Menor turgencia del pene erecto debido a la pérdida de elasticidad de los vasos sanguíneos y de la potencia de los músculos.
	Menor y más lento ascenso testicular durante la excitación por laxitud del cremáster.
	La eyaculación se retrasa y también la sensación de que la eyaculación es inevitable, lo que se convierte en una ventaja para los eyaculadores precoces.
	Menor necesidad física de eyacular. Menor producción del líquido pre-eyaculatorio. Menos volumen y calidad funcional de esperma eyaculado.
	Menor número e intensidad de las contracciones orgásmicas.
	Aumenta mucho el periodo refractario tras la erección, lo que puede hacer necesario el transcurso de varios días antes de conseguir otra erección completa.
	Eyaculación en un porcentaje inferior al 100% de los coitos.

Necesidades especiales de atención y apoyo integral.

Antaño en las residencias la atención era exclusivamente sanitaria dejando a un lado la vertiente social de las personas, solamente se cubrían las necesidades básicas (higiene, alimentación, techo, etc.).

En la actualidad, nos planteamos un modelo de atención individual y personalizada, una intervención centrada en las necesidades concretas de cada caso en las diferentes áreas implicadas, tales como auto-cuidado, autonomía, relaciones interpersonales, tiempo libre y estimulación cognitiva.

El diseño de todas las acciones terapéuticas estará dirigido, obviamente, hacia la atención de las necesidades más básicas y, con igual importancia, hacia otras necesidades complementarias.

En este contexto, cobra especial importancia el concepto de Actividades de la Vida Diaria (AVD), que son “aquellas actividades que una persona ha de realizar diariamente para poder vivir de forma autónoma, integrada en su entorno habitual y cumpliendo su rol social”. Estas actividades se pueden clasificar en tres grandes grupos:

I. Actividades BÁSICAS de la Vida Diaria (ABVD).
II. Actividades INSTRUMENTALES de la Vida Diaria (AIVD)
III. Actividades AVANZADAS de la Vida Diaria (AVDA).

I. ABVD

Son el conjunto de actividades primarias de la persona, encaminadas a su autocuidado y movilidad y a la capacidad de entender y ejecutar órdenes y tareas sencillas, que le dotan de autonomía e independencia elementales y le permiten vivir sin precisar ayuda continua de otros.

Entre ellas se incluyen actividades como:

- Actividades de autocuidado: asearse, vestirse y desnudarse, poder ir solo al servicio, poder quedarse solo durante la noche, comer y beber,…
- Actividades de funcionamiento básico físico: desplazarse dentro del hogar; desplazarse fuera del hogar; realizar transferencias corporales -sentarse, tumbarse, ponerse de pie,…
- Actividades de funcionamiento básico mental: reconocer personas y objetos; orientarse; entender y ejecutar instrucciones y tareas sencillas; tomar decisiones (para personas con discapacidad mental o intelectual).

Pueden ser medidas con los siguientes instrumentos: Escala de Barthel, Oars Scale y Escala de Katz.

II. AIVD

Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD): son las que permiten a la persona adaptarse a su entorno y mantener una independencia en la comunidad; incluyen actividades como: telefonear, comprar, cocinar, cuidar la casa, utilizar transportes, manejar la medicación, manejar el dinero, etc.



Las escalas para las AVDI correlacionan mejor con el estado cognitivo y por ello pueden utilizarse para la detección precoz del deterioro. Para evaluar correctamente los ítems de estas escalas resulta importante diferenciar si el paciente realiza habitualmente esa actividad o si, por el contrario, no podría llevarla a cabo.



Entre las más utilizadas tenemos: Índice de Lawton y Brody y la Oars Scale.

III. AVDA

Valoran funciones más complejas como la realización de actividades de ocio, religiosas, deportes, trabajos, transporte… también se incluyen en la escala de Lawton y Brody.

Calidad de vida, apoyo y autodeterminación en la persona mayor.

Cada persona es diferente y responder a las necesidades de cada caso requiere una responsabilidad distinta. El reconocimiento de que toda persona tiene derecho a la autodeterminación y a ser considerada de forma individual para que pueda llegar a ser autosuficiente, es esencial para que pueda elegir ella misma las reglas de su conducta y la dirección que quiere dar a su existencia.

No se trata de plantearnos la intervención como un servicio prestado a una persona que posee determinadas carencias, sino de considerar nuestra tarea profesional como el medio para que dicha persona pueda desenvolverse por sí misma, más allá del daño o limitación que posea, reconociendo el derecho que tiene a encargarse de su propia vida.

Además de trabajar en el ámbito de las necesidades elementales, también supone desarrollar una atención complementaria a las actuaciones básicas. Añadiremos acciones terapéuticas que activen, en la persona dependiente, otras áreas más específicas de su vida con el objetivo de promover su calidad de vida y trabajaremos sobre lo más individual de cada residente.

Para fomentar la autodeterminación de nuestros usuarios podemos planificar actividades con las que puedan participar en la comunidad, e incluso formar parte de grupos. De este modo, y por otro lado, también serán atendidas, al menos en parte, sus necesidades afectivas y relacionales. Nos referimos en concreto a:

- Actividades para el fomento de la relación social.
- Actividades recreativas y educativas.
- Ocupación de la persona en propuestas de tiempo libre saludables; etc.

En función de cada valoración individual, resultado de la evaluación de necesidades personales, planificaremos actividades, recursos y estrategias dirigidas hacia la promoción de la calidad de vida y bienestar de cada individuo.

Características y necesidades en enfermedad y convalecencia

En el proceso de la enfermedad se distinguen las siguientes etapas:

1. Aparición de los síntomas: primeras señales de la enfermedad. En esta etapa podemos encontrar dos comportamientos distintos:
    a. El enfermo afronta el problema y adopta medidas para solucionarlo,
    b. Niega lo que sucede y no toma medidas
2. Conciencia de la enfermedad: el paciente admite sentirse enfermo
3. Contacta con los servicios sanitarios, busca un diagnóstico
4. Estado de enfermedad: síntomas propios de la enfermedad y consecuencia de los fármacos. Esta etapa se caracteriza por la dependencia de otros (familia, personal sanitario, amigos...)
5. Convalecencia: período de tránsito entre la enfermedad y la total recuperación
6. Curación, cronificación o muerte: la cronificación supone que la persona necesitará cuidados y atención durante un periodo lago o incluso durante toda la vida. La muerte sucede cuando no se supera la enfermedad.

Las personas con ENFERMEDADES AGUDAS, se caracterizan por tener una afección (enfermedad) de duración determinada y de aparición repentina. Salvo complicaciones, las enfermedades agudas remiten después de administrar un tratamiento. La convalecencia es menos traumática y rápida cuando el paciente permanece en su entorno (familia, cuidadores habituales...) (Algunas enfermedades agudas. Gripe, gastroenteritis, cefaleas...)

En las personas con ENFERMEDADES CRÓNICAS, la enfermedad afectará durante varios años, incluso toda la vida. El tratamiento se orienta a la enfermedad y a sus efectos para evitar que la enfermedad progrese. En este tipo de enfermedades es importante que el paciente aprenda hábitos de autocuidados. (Algunas enfermedades crónicas: asma, hipertensión arterial, diabetes,..)

Pacientes con ENFERMEDADES TERMINALES son aquellos que padecen una enfermedad incurable avanzada, la intervención se centrará en aplicar cuidados paliativos para aliviar el dolor y mejorar el confort en el último tramo de su vida.

La enfermedad conlleva además del propio padecimiento cambios en la imagen de sí mismo y en la autoestima. También altera negativamente el estado de ánimo y la relación con otras personas. Se producen cambios en la vida familiar, cambios de rol, dificultades en la realización de tareas, pudiendo incluso ser una carga económica.

La forma adecuada de desarrollar el acompañamiento, cuidado y apoyo al enfermo es creando un clima e interacción positiva con:

- Empatía[35].
- Autenticidad, congruencia entre lo que se hace y se siente.
- Aceptación, no juzgar al enfermo, admitir la enfermedad incondicionalmente

Las NECESIDADES DE LA PERSONA ENFERMA son las mismas que las de la persona sana pero debido a que en esta es posible, en función del grado de dependencia que genera la enfermedad, que no las pueda cubrir por si misma.

Las Necesidades Humanas Básicas en la persona dependiente son

Necesidad de Oxigenación:

Esta necesidad está condicionada por las limitaciones orgánicas propias del proceso de deterioro y por la disminución del gasto físico.

Factores que intervienen en el mantenimiento de la independencia:

- Una correcta alineación favorecerá la capacidad de expansión de la caja torácica.
- Realización de ejercicio físico adecuado a sus limitaciones.
- Higiene según los hábitos, el vestido y el calzado favorecerán una correcta oxigenación.
- Una dieta equilibrada mantendrá una hidratación y peso adecuado para el funcionamiento orgánico correcto.
- La situación psíquica es importante para la satisfacción de esta necesidad.
- Cambios emocionales pueden influir en el patrón respiratorio, como ansiedad, estrés, etc.
- Clima, altitud, medio ambiente, vivienda. Todos ellos pueden influir sobre esta necesidad.

[35] Capacidad de comprender emociones, pensamientos de los demás. (ponerse en lugar del otro.

- Tipo de vida y costumbres del anciano pueden favorecer la autonomía.

Manifestaciones de dependencia:

- Problemas por déficit o insuficiencia orgánica por falta de expectoración, debilidad muscular, y alteraciones cardiocirculatorias.
- Problemas asociados a inmovilidad, hipertensión, afecciones crónicas y situaciones de estrés.

Necesidad de alimentación:

Necesidad vital para el mantenimiento de la vida y para permitir el correcto funcionamiento orgánico.

Factores que intervienen en la independencia:

- Correcto estado de boca y dientes.
- Funcionamiento del aparto digestivo de forma adecuada.
- Capacidad para manipular y preparar alimentos.
- Conocimiento de alimentos que beneficien y perjudiquen su salud.
- Nivel de conocimientos para manipular y conservar alimentos.
- Estado emocional que permita al anciano manipular los alimentos
- Estado emocional equilibrado que estimule al ingestión de alimentos
- Accesibilidad a los alimentos, clima y situación geográfica.
- Características de la vivienda que favorezcan la independencia.
- Situación económica que permita el mantenimiento de la boca.
- Costumbres y tradiciones que influyan en esta necesidad.

Manifestaciones de dependencia:

- Problemas originados por déficit de nutrientes: malnutrición, anemias, incapacidades físicas, depresiones y hábitos tóxicos.
- Problemas derivados de la sobrecarga del organismo: obesidad, hipertensión, problemas hepáticos, dolor y ansiedad.



Necesidad de Eliminación:

La eliminación de las sustancias de deshecho del metabolismo es vital para el funcionamiento del organismo. Para deshacernos de esta es necesaria la conjunción de diversos sistemas del individuo sano.

Factores que intervienen en la Independencia:

- Para satisfacer esta necesidad la capacidad física resulta básica para la independencia del anciano.
- El vaciado de la vejiga se conseguirá con una correcta respuesta muscular y del mantenimiento del peristaltismo intestinal.
- A la misma vez se favorecerá la movilidad y el desplazamiento.
- Correcto funcionamiento renal, digestivo y glandular.
- La autosatisfacción se conseguirá con el correcto control de esfínteres.
- Los requerimientos orgánicos de la eliminación de la persona dependiente se conseguirán a través de su capacidad intelectual y de coordinación motora.
- Las emociones, pérdidas, cambios y situaciones de estrés pueden afectar a los hábitos eliminatorios.
- Un ambiente tranquilo y la conservación de la intimidad son factores que condicionan la consecución de una correcta eliminación.
- Las normas sociales del grupo de pertenencia, la forma de controlar la eliminación y las creencias personales son factores que pueden condicionar la satisfacción individual de esta necesidad.
- Los elementos físicos inadecuados de la vivienda, como la existencia de suelos antideslizantes, barandas para apoyarse en el inodoro y en la ducha o bañera, condicionarán de la misma forma la autonomía.

Manifestaciones de dependencia:

- Problemas que aparecen a consecuencia de los déficits: incontinencia fecal o urinaria, dolor y trastornos psíquicos.
- Problemas a consecuencia de la sobrecarga: limitaciones en la eliminación por inmovilización, enfermedades degenerativas, situaciones postquirúrgicas, infecciones , hemorroides , fístulas , tumoraciones , desorientación .

Necesidad de Moverse y mantener buena postura:



Factores que intervienen en la independencia:

- Un funcionamiento adecuado del músculo esquelético y del sistema nervioso es esencial para la independencia de la movilización del anciano.
- El buen mantenimiento de fuerza muscular y movilidad de las articulaciones favorecerá en la capacidad de moverse y mantener una buena alineación del cuerpo.
- Precisará el mantenimiento de un grado de inteligencia justo que permita una adecuada coordinación psicomotriz.
- Para conseguir una correcta respuesta motriz será necesario un buen estado anímico y mental equilibrado.
- Factores como creencias, valores, y cultura favorecerán o evitarán la movilidad, relajando los impulsos y motivaciones individuales.
- Influencia climática, el tipo y lugar de residencia, condiciones de vivienda y del entorno y la supresión de las barreras arquitectónicas vana ser factores que favorezcan o reduzcan las posibilidades de movilidad de la persona dependiente.

Manifestaciones de dependencia:

Para conseguir una movilización independiente será necesaria la coordinación entre las actividades muscular, nerviosa y ósea. Los problemas más frecuentes son:

- Problemas originados por déficits de inmovilidad.
- Problemas originados por sobrecarga.

Necesidad de reposo y sueño:

Factores que intervienen en la Independencia:



- Un buen funcionamiento corporal constituya la base de la independencia.
- El exceso de grasa o la inactividad pueden influir negativamente en el sueño.
- Los estados depresivos y las perdidas afectivas suelen ser las causas más frecuentes de la perturbación del sueño de la persona dependiente.
- La capacidad de relajación es directamente proporcional a la profundidad del sueño.
- Factores sociales relacionados con la vivienda, cama que pueden influir en esta necesidad.
- El lugar de residencia no habitual o compartir la habitación con otras personas puede producir dificultades en la satisfacción.

Manifestaciones de dependencia:

- Problemas originados por el déficit: insomnio, disnea, incontinencia, perdida afectiva y déficit alimentario.
- Problemas originados por sobrecarga: ansiedad, estrés , problemas cerebrales y circulatorios.

Necesidad de Higiene y arreglo personal:



Factores que intervienen en la Independencia:

- La capacidad funcional será esencial para la independencia.
- El estado de piel, cabello, manos y uñas favorecerá la individualidad del anciano en cuanto a la higiene.
- La diferencia entre sexos las tendremos que tener en cuenta.
- La capacidad de coordinación psicomotriz pondrá en marcha al individuo para realizar su higiene.

- El estado anímico influirá en la motivación que tenga la persona dependiente.
- El mantenimiento de la intimidad será un factor determinante para la satisfacción de esta necesidad.

Manifestaciones de dependencia:

- Problemas originados por déficit: alteraciones motrices, dolor, limitaciones psíquicas, depresión y falta de fuerza.
- Problemas originados por sobrecarga: asociados a ulceras infecciones falta de motivación, prurito, traumatismos, dermatitis, callosidades y uñas encarnadas.

Necesidad de mantener la Temperatura corporal:

Durante el envejecimiento el centro termorregulador se vuelve menos eficaz. En el anciano por tanto hay descensos de temperatura en situaciones normales, sintiendo frío o calor en diferente grado que el adulto.

Factores que intervienen en la Independencia

- El ejercicio físico a la misma vez que estimula el movimiento reproduce calor corporal.
- También se genera calor a través de la ingestión de alimentos ricos en proteínas que estimulan el metabolismo corporal.
- El cambio de temperatura según la hora del día influye en la persona dependiente. Mientras que el punto álgido de la temperatura corporal se produce sobre las últimas horas de la tarde la temperatura mínima alcanzada por el organismo se da hacia las primeras horas de la madrugada.
- En la regulación de la temperatura intervienen las emociones y la ansiedad, aumentándola o disminuyéndola.
- El medio ambiente en el que se desenvuelve la persona dependiente puede ser causa de dificultad en el mantenimiento de la temperatura.
- Las costumbres y la cultura van a condicionar el tipo de vestido que éste utilice para mantener la temperatura.
- Las características de la institución (calefacción, instalaciones de agua caliente, ajustes de ventanas y puertas) ofrecerán confortabilidad ambiental y contribuirán a mantener la temperatura corporal de la persona dependiente.

Manifestaciones de dependencia:

- Los problemas que con mayor frecuencia causan esta incapacidad:
- Problemas originados por déficits: hipotermias, problemas de hiperfuncionamiento hormonal, problemas circulatorios, tumoraciones, insuficiente calor ambiental, cambios bruscos de temperatura, ingestión en hidratación insuficiente, depresiones.
- Problemas originados por sobrecarga: hipertermias asociadas a hiperfunciomaniento hormonal, excesivo calor ambiental, utilización de

vestidos inadecuados, ingestión e hidratación excesiva, exagerada exposición al frío o al calor.

Necesidad de Evitar Peligros:

Factores que intervienen en la Independencia

- Buen funcionamiento del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos.
- Capacidad motora mantenida.
- Correcto funcionamiento orgánico para mantener la seguridad.
- Mantener el equilibrio psíquico y conservar la capacidad intelectual.
- El carácter puede influir a la hora de sufrir accidentes.
- El medio cultural y la educación influyen en el mantenimiento de un entorno seguro.
- Recursos que disponga el anciano para evitar peligros.
- Riesgos ambientales, como humos, ruido, tráfico y contaminación.
- Inadecuación del medio, la no modificación de barreras arquitectónicas

Manifestaciones de dependencia:

- Problemas originados por déficit: fragilidad por desequilibrios físicos o psíquicos, agresiones ambientales, pobreza y polución.
- Problemas originados por sobrecarga: infecciones, dolor, incoordinación motriz, hiperactividad y estrés.

Necesidad de Comunicarse:

Factores que intervienen en la Independencia

- Mantenimiento de las capacidades sensoriales y del sistema nervioso (ver, oler, tocar y sentir)
- Integridad de las cuerdas vocales para la emisión de la voz.
- Funcionamiento orgánico que le permita su sexualidad.
- Nivel de inteligencia que le permite la comunicación.
- El equilibrio emocional influye en la calidad de la comunicación.
- La experiencia de comunicaciones inefectivas condiciona nuevas relaciones.
- El conocimiento de las relaciones sexuales.
- Las características del entorno influyen en una buena comunicación.
- El medio social y cultural en el que se desenvuelve el anciano.
- La disponibilidad económica facilita la comunicación.
- Los medios de la comunidad que favorezcan o entorpezcan la relación.
- Los cambios rápidos de la comunicación de masas son a veces causa de problemas en la comunicación de la persona dependiente.

Manifestaciones de dependencia:

- Incomunicación por perdidas sensoriales, problemas del sistema nervioso, depresión y soledad.
- ACV (accidentes cerebrovasculares), cataratas, inmovilización, traumatismos, tumores, uso de fármacos hipnóticos y antidepresivos, ansiedad, estrés y sentimiento de culpa

Necesidad de expresar la sexualidad:



Factores que intervienen en la Independencia

- Mantenimiento de la movilidad para desplazarse, moverse y relacionarse.
- Mantenimiento de capacidades sensoriales.
- Mantenimiento de la capacidad de estimulación.
- Capacidad de responder a los estímulos.
- Autoaceptación de cambios del envejecimiento (arrugas, canas, etc.)
- La situación afectiva que disfrute la persona dependiente, según mantenga una pareja estable o este soltero o viudo.
- Capacidad de adaptación a nuevas situaciones afectivas, cambios de domicilio, etc.
- Consideración de necesitar la expresión de la sexualidad (heterosexualidad u homosexualidad) .
- La influencia de relaciones o experiencias anteriores.
- El estímulo por mantener la creatividad en la relación sexual.
- La educación recibida y el nivel cultural desarrollado por el anciano a lo largo de su vida.
- Las diferencias según el sexo.
- Lugar de residencia: domicilio propio, domicilio de los hijos, institución, etc.

Manifestaciones de dependencia:

- En el hombre: Impotencia, falta de erección y fallos en la eyaculación.
- En la Mujer: Falta de lubricación y falta de apetito sexual.
- En ambos : Cambios de autoimagen
- Problemas ginecológicos en la mujer: prolapsos, carcinomas, etc.
- En el hombre: carcinomas y tumoraciones.
- En ambos: problemas articulares, diabetes, cardiopatías, bronquitis, espasmos dolor , etc.

Necesidad de elegir según los valores y las creencias:

Factores que intervienen en la Independencia

- Será un factor determinante a la hora de satisfacer autónomamente la necesidad de energía, ya que podrá exteriorizar su forma de pensar a través de gestos y expresiones.
- El estado mental y el mantenimiento de las capacidades intelectuales permitirán al anciano a actuar y vivir según sus creencias.
- La exteriorización de sus emociones expresará la forma del anciano de vivir sus experiencias y determinará sus intereses.
- Expresión del deseo de búsqueda o de la esencia de la propia vida, de la naturaleza y de la energía.
- Factores culturales, educacionales, y grupales serán la base de sus creencias y de sus valores sobre la vida.
- La religión podrá influir en la forma de actuar ante diferentes situaciones.

Manifestaciones de dependencia:

- Incapacidad asociada al desequilibrio psíquico, crisis, falta de afirmación, situaciones de pérdida, conflictos de autoestima, sentimientos de culpabilidad, falta de motivación.
- Desvalorización asociada a enfermedades invalidantes, demencias, frustraciones, ansiedad vulnerabilidad a enfermedades, problemas de incapacidad sensorial.

Necesidad de Autorrealización:

Factores que intervienen en la Independencia

- Un buen funcionamiento orgánico permite al anciano se autónomo y realizar actividades de su agrado.
- La capacidad psíquica mantenida, la motivación y el dar un sentido a la vida serán los factores que mantienen una actividad para que se sienta realizado.
- La situación económica permitirá al anciano el disfrute de ciertas actividades.
- La comunidad en que se mueva o grupo de pertenencia, le incluirán o excluirán de las actividades

Manifestaciones de dependencia:

- Desinterés asociado a falta de motivación, depresión, baja autoestima, soledad, aislamiento y situaciones de perdida.
- Inadaptación asociada a problemas de desorientación, demencias, tumores, problemas sensoriales, traumatismos y estrés.

Necesidad de Aprender:



Factores que intervienen en la Independencia

- La capacidad sensorial que mantiene es un factor preciso para favorecer el aprendizaje.
- Parece que el mantenimiento de las capacidades psíquicas es un factor fundamental que interviene en el aprendizaje.
- El estado anímico puede favorecer la satisfacción de esta necesidad.
- La motivación generará en el anciano el interés necesario para aprender.
- El medio cultural, el estilo de vida, los problemas estructurales, la vivienda, los medios económicos condicionan el aprendizaje.
- Los recursos que cuenta la sociedad que fomenten el interés por aprender.

Manifestaciones de dependencia:

- Problemas originados por déficit: falta de motivación, disminución sensorial, depresión, falta de interés debilidad psicomotriz y disminución de la capacidad de aprendizaje.
- Problemas originados por sobrecarga: resistencia asociada a problemas psíquicos, demencia, estrés y dolor.

2.3.- Discapacidades en las personas dependientes:

Concepto.

La discapacidad es la pérdida de la capacidad, ya sea física o mental. Es una patología muy frecuente que conlleva múltiples complicaciones para el paciente y es el estadio final de muchos trastornos.

La situación funcional del anciano puede considerarse como un marcador de bienestar.

Clasificación y etiologías frecuentes.

Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) las personas no son las unidades de clasificación; es decir, la CIF no clasifica personas, sino que describe la situación de cada persona dentro de un conjunto de dominios de la salud o dominios "relacionados con la salud". Además, la descripción siempre se hace en el contexto de los factores ambientales y personales.

Estos últimos no se incluyen en la clasificación de la CIF pero si que condicionan la clasificación como se muestra en el siguiente diagrama donde se expresan las interacciones entre los diferentes componentes de las CIF:

La clasificación de la discapacidad en la CIF atiende a criterios etiológicos (causas) y se dan las siguientes:

1.- Discapacidades relacionadas con las funciones corporales en lo referente a:

- Funciones mentales
- Funciones sensoriales y dolor
- Funciones de la voz y el habla
- Funciones de los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico y respiratorio
- Funciones de los sistemas digestivo, metabólico y endocrino
- Funciones genitourinarias y reproductoras
- Funciones neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento
- Funciones de la piel y estructuras relacionadas

2.- Discapacidades relacionadas con las estructuras corporales en lo referente a:

- Estructuras del sistema nervioso
- El ojo, el oído y estructuras relacionadas
- Estructuras involucradas en la voz y el habla
- Estructuras de los sistemas cardiovascular, inmunológico y respiratorio
- Estructuras relacionadas con los sistemas digestivo, metabólico y endocrino
- Estructuras relacionadas con el sistema genitourinario y el sistema reproductor
- Estructuras relacionadas con el movimiento
- Piel y estructuras relacionadas



3.- Discapacidades relacionadas con la actividad y participación en lo referente a:



- Aprendizaje y aplicación del conocimiento
- Tareas y demandas generales
- Comunicación
- Movilidad
- Autocuidado
- Vida doméstica
- Interacciones y relaciones interpersonales
- Áreas principales de la vida
- Vida comunitaria, social y cívica

4.- Discapacidades relacionadas con los factores ambientales en lo referente a:

- Productos y tecnología
- Entorno natural y cambios en el entorno derivados de la actividad humana
- Apoyo y relaciones
- Actitudes
- Servicios, sistemas y políticas

En la dirección electrónica http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO4989/ciffinalb.pdf se muestran ampliamente desarrolladas todas las discapacidades citadas

Otra manera de *clasificar la discapacidad es en función al grado de dependencia.*

La severidad de la discapacidad hace referencia al grado de dificultad para realizar una determinada actividad, con o sin ayudas. Teniendo en cuenta la severidad se establecen tres grados de discapacidad:

NO hay deficiencia –	Ninguna. Ausencia de deficiencia o deficiencia insignificante.	0 -4%
Deficiencia LIGERA –	Poca o escasa.	5-24%
Deficiencia MODERADA –	Media o regular.	25-49%
Deficiencia GRAVE –	Mucha o extrema.	50-95%
Deficiencia COMPLETA –	Total.	96-100%

En la siguiente página web se recogen diferentes enlaces relacionados con la discapacidad: http://usuarios.discapnet.es/disweb2000/docu/index.htm

ETIOLOGIA

Son cuatro los grupos de riesgo de padecer discapacidad:

1. Problemas en el desarrollo fetal y en el parto
   - Malformaciones genéticas (Down, trisomias…)
   - Embarazos de riesgo (edad avanzada de la madre, estado físico y psíquico de la madre, anomalías genéticas…)
   - Nacimientos pretérmino y de bajo peso
   - Daño obstétrico (anoxia, traumatismos…)
2. Accidentes (Tráficos, laborales, hogar, colegio…)
3. Enfermedades crónicas
4. Tercera edad

Características y necesidades.

Hablar de cuales son las características generales de las personas discapacitadas es muy complicado porque depende del tipo de discapacidad, de los factores ambientales y de la manera de ser de la persona discapacitada. Aun así y todo si se pueden establecer unas características que se pueden considerar como generales y son:

- Inseguridad y baja autoestima
- Excesiva dependencia, en ocasiones ocasionada por la sobreprotección.
- Infravaloración de las capacidades reales de la persona discapacitada
- Dificultades de relación

Las personas discapacitadas tienen las mismas necesidades que las no discapacitadas y son las que se recogen en el apartado “Características y necesidades en enfermedad y convalecencia”. Un breve resumen adecuado a las personas con discapacidad s necesidades:

- Quieren y pueden decidir, no debemos hablar por ellos y si están presentes debemos dirigirnos a ellos y no a sus acompañantes.
- Cada cual tiene se ritmo y hay que respetarlo
- Necesitan en ocasiones ayuda, pero recordando que ayudar es acompañar y nunca hacer las cosas que puede realizar por él.
- A los adultos tratarlos como tal y no como niños.
- Necesitan saber, estar informados de lo que les sucede y de lo que sucede en su entorno y en la sociedad en general. Hay que contarles la verdad, hasta donde ellos quieran conocer, de forma clara y que puedan entender.
- Necesitan de relaciones sociales
- Necesitan intimidad.
- Pueden aportar por lo tanto hay que escucharles

En el siguiente enlace se recoge información sobre las necesidades de las personas con discapacidad http://yct.feapsmadrid.org/ . Esta relacionado con la discapacidad intelectual pero es extensible en muchos aspectos a cualquier otro tipo de discapacidad

Calidad de vida, apoyo y autodeterminación de las personas con discapacidad.

Calidad de vida y autodeterminación, son dos conceptos que en los últimos años se han relacionado entre si.

CONCEPTO DE CALIDAD DE VIDA.

Calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la realización del as potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como aspectos subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad personal y la salud objetiva. Como aspectos objetivos, el bienestar material, las relaciones armónicas con el ambiente físico y social y con la comunidad, y la salud objetivamente percibida

EL CONCEPTO DE AUTODETERMINACIÓN.

Se define como el proceso por el cual la acción de una persona es el principal agente de su propia vida y de las elecciones y toma de decisiones sobre su calidad de vida, libre de influencias externas

Por lo tanto autodeterminación y calidad de vida están relacionadas, ya que ser responsable de las decisiones adoptadas revierte positivamente en la personas mejorando la autoestima.

Estos conceptos son los que se están manejando en la actualidad sobre todo en el caso de las personas con discapacidad intelectual. En este caso de las personas se les niega la posibilidad de decidir sus propios proyectos de vida, con la finalidad de protegerles, evitarles frustraciones, o simplemente por costumbre.

Nuestra tarea será facilitar a las personas con discapacidad su derecho a elegir lo que conllevará a aumentar la motivación para realizar las tareas y disminuir los comportamientos desajustados porque se experimenta calidad de vida cuando se tienen las mismas oportunidades que el resto.

En relación con estas ideas surge el PARADIGMA DE APOYOS que cree en la capacidad de las personas y fomenta su autonomía. El paradigma de los apoyos se basa en la detección de las limitaciones para aportar los apoyos individualizados.

Entiende por *apoyos* los recursos y estrategias que:

- promueven los intereses y las “causas” de las personas con o sin discapacidades
- les capacitan para acceder a recursos, información y relaciones en entornos de trabajo y de vida integrados
- incrementan su interdependencia/independencia, productividad, integración en la comunidad y satisfacción

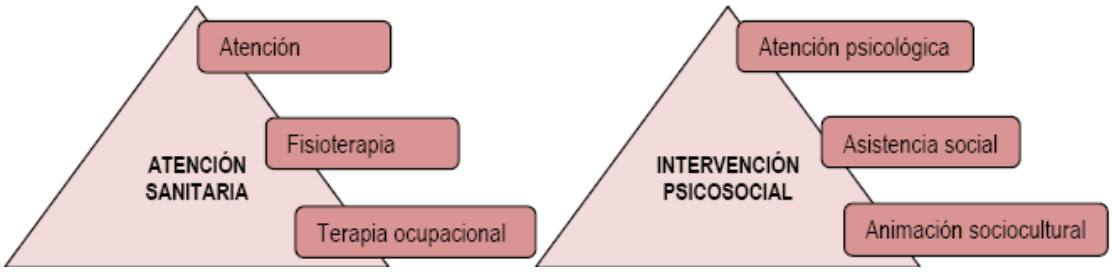
Los apoyos vienen dados desde:

LAS INSTITUCIONES para aquellos pacientes que necesitan de otra persona en la realización de las actividades de la vida diaria y no pueden ser atendidos por su familia, existen distintos tipos de centros sociales con servicios y programas de intervención adecuados a las necesidades de las personas dependientes.

Los distintos tipos de recursos pueden ser clasificados en:

Residencias para personas gravemente afectadas, que atienden a personas con discapacidad física, retraso mental, parálisis cerebral, trastornos del espectro autista, graves problemas de conducta o deterioro mental (bien sea por su edad o como consecuencia de la discapacidad intelectual). Desde este tipo de institución social generalmente se ofrecen programas de:

- Atención sanitaria, que engloban actuaciones para la atención, la fisioterapia y la terapia.
- Intervención psicosicial, que incluye actuaciones para la atención, la asistencia y la animación.



Además, en un centro sociosanitario de estas características pueden ser desarrollados programas específicos para personas con deterioro cognitivo o incluir una unidad de cuidados paliativos para la atención de pacientes terminales.

Unidades de estancia diurna, donde se atiende a pacientes durante una parte del día, con idénticos servicios y programas de intervención que los comprendidos en el servicio de atención residencial. Son un apoyo a los cuidadores informales; es decir, a las personas que cuidan en casa a familiares en situación de dependencia.

Servicios de centro de día y de noche de atención especializada, que ofrecen tratamientos adecuados a peculiaridades de la edad y necesidades de apoyo intermitente, limitado, extenso o generalizado de las personas en situación de dependencia.

EL PERSONAL EN LA RELACIÓN PROFESIONAL-USUARIO

El tipo de apoyo técnico y personal que ofreceremos al usuario dependerá de la evaluación funcional de sus habilidades y discapacidades en relación a las demandas ambientales de su entorno que, en estos casos, es el centro residencial. Una vez hayan sido valorados el nivel de competencia personal y las áreas de necesidades sobre las que intervenir, el equipo técnico desarrollará una planificación estructurada dirigida a la rehabilitación de cada usuario en concreto. Ésta se realizará a partir de un entrenamiento específico y contextualizado de aquellas habilidades que la persona necesita lograr para compensar de este modo sus dificultades físicas, psíquicas o sociales y disfrutar de las oportunidades que ofrece la integración social.

El equipo de profesionales de ASPRONAS (Valladolid) ha elaborado el cuaderno de buenas prácticas que lo podéis consultar en la siguiente dirección:

http://www.feaps.org/biblioteca/libros/documentos/autodeterminacion_bbpp.pdf

3. Acompañamiento de las personas usuarias

3.1.- Concepto de acompañamiento de las personas dependientes en la institución.

El acompañamiento a las personas dependientes en la institución consiste en entablar un vínculo de ayuda entre el profesional sanitario y la persona usuaria, nunca haremos lo que la persona usuaria puede hacer.

El acompañamiento de las personas dependientes por parte del profesional sanitario implica:

- Dedicarles el tiempo suficiente.
- Compromiso, cuidado y paciencia.
- Comunicación afectiva, escucha y buen humor.
- Cercanía - persona accesible que no crea dependencia personal.
- Respeto - crea confianza e igualdad en el trato-.
- Capacidad de negociación; realista y flexible.

Se trata de estar al lado ni delante ni detrás.

3.2.- Áreas de intervención, límites y deontología.

AREAS DE INTERVENCIÓN

Las áreas de intervención en las instituciones quedan reflejadas en programas de intervención, en la que se proporcionan una serie de orientaciones y directrices prácticas que se espera faciliten el desarrollo de la práctica profesional. Los programas:

- programa de intervención psicoterapéutica,
- programa de intervención sanitaria,
- programas de intervención ocupacional
- programa de intervención con familias,
- programa de intervención con el entorno,

La finalidad de todos los programas es proporcionar una atención integral a la persona mayor dependiente para:

- Recuperar y/o mantener el mayor grado de independencia posible.
- Retrasar o prevenir el incremento de la dependencia a través de la potenciación y rehabilitación de sus capacidades cognitivas, funcionales y sociales.
- Desarrollar la autoestima y favorecer un estado psicoafectivo adecuado.
- Evitar o retrasar institucionalizaciones definitivas no deseadas o desaconsejables.

La coordinación entre los distintos profesionales del centro (médico geriatra, personal de enfermería, terapeuta ocupacional, cuidadores, etc.) resulta

indispensable, debiendo existir una colaboración coherente y cooperativa entre los diferentes equipos y servicios que atienden al usuario.

LÍMITES EN LA INTERVENCIÓN

El cuidador debe aplicar las estrategias diseñadas por el equipo interdisciplinar competente siguiendo el principio de la coherencia institucional; es decir:

Estos serán los límites de su actuación:

- los que el usuario imponga por su estado físico y psíquico
- los que la institución y el equipo interdisciplinar imponga

Conocerá y respetará la demanda del paciente, el proyecto de intervención y el reglamento de régimen interno de la institución donde trabaja.

Alguno de los límites que debemos evitar en el acompañamiento son:

Evitar aumentar la dependencia,

Cuando se trabaja con personas dependientes caemos con frecuencia en la tentación de “ayudar” por encima de lo necesario, nos hace sentirnos bien y la persona usuaria lo agradece. Sin embargo esta actitud no fomenta la autote impulsa la dependencia sobrepasando los límites del acompañamiento

Evitar la manipulación

La manipulación de las situaciones se da por las dos partes

Cuando el profesional cuando actúa contra la voluntad de la persona usuaria porque ya sabe él lo que es mejor, sin tener en cuenta las necesidades de la persona usuaria y tiende a dirigirlo hacia esa opción.

Cuando por parte del usuario utiliza el acompañamiento para realizar tareas que le incomodan o le cuestan.

Evitar el abuso físico



El acompañamiento implica cercanía emocional y cercanía física, con abrazos, caricias, formas adecuadas de expresión pero siempre respetando la intimidad del paciente ya que esa intimidad no es bien tolerada por todo el mundo,

cada uno tiene sus propios límites respecto al contacto. De la misma manera el profesional tampoco debe consentir contactos por parte del usuario que le puedan poner en situaciones incomodas.

DEONTOLÓGIA

En el apartado 2.1.- atención a las personas dependientes según su grado de dependencia. Del MF 1 UD 1 ya se hablo del código deontológico y de las actitudes y valores exigibles en el profesional sociosanitarioa.

Un código deontológico es un documento que recoge un conjunto más o menos amplio de criterios, apoyados en la deontología con normas y valores que formulan y asumen quienes llevan a cabo correctamente una actividad profesional, en nuestro caso la asistencia sociosanitaria. Los códigos deontológicos se ocupan de los aspectos éticos del ejercicio de la profesión que regulan.

Los criterios deontológicos son de obligado cumplimiento, ya que constituyen un conjunto de principios y normas éticas que orientan la acción y la conducta profesional. En el caso de la atención sociosanitaria se han estableado los siguientes principios:

Principio de bienestar

El profesional es el responsable de prestar la mejor atención posible a todos y cada unos de los usuarios sin realizar ningún tipo de diferencia por la causa que sea.

Principio de individualidad del usuario

Cada persona usuaria es única y diferente a las demás y como tal debe ser considerado, sin clasificarla en estereotipos.

Principio de aceptación

La persona usuaria es como es y así hay que aceptarla, sin pretender alterar los rasgos de su personalidad. Hay que acercarse a ella sin ningún tipo de prejuicio.

Principio de autodeterminación

La persona dependiente debe hacer sus propias elecciones lo que no impide que se le muestren distintas alternativas con el objeto de motivarlo.

Principio de secreto profesional

Hay un dicho que dice que “lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas”, pues aplícatelo, toda la información



obtenida por ser necesaria para desarrollar la labor asistencial nunca debe trascender fuera de la institución., ni nombres, ni patologías, ni visitas, ni comportamientos, ni ningún otro dato. De la misma manera que entre el equipo profesional solo divulgaremos la información necesaria para la asistencia integral.

3.3.- Funciones y papel del profesional en el acompañamiento.

La función y papel principal del profesional en el acompañamiento es SER GUÍA, apoyo y fuente de procedimientos favorecedores para la persona dependiente, en colaboración al trabajo en equipo de la institución.

Las funciones del profesional de acompañamiento son:

- APOYAR al residente supone ayudar al usuario a activar sus propios recursos psicológicos y emocionales.

  Dar apoyo emocional supone empatizar con el usuario, escuchar y comprender sus pensamientos y preocupaciones, lo cual hará que aumente la confianza y permita al residente expresar sus sentimientos.

- MOTIVAR a que el usuario sea responsable de su proyecto vital, de tomar decisiones, animar al autocuidado, fomentar la autonomía personal animando a que realice las tareas que pueda hacer él solo. Todo ello hará que mejore la confianza y la autoestima del residente.

- SUPERVISAR el correcto desarrollo de la realización de actividades cotidianas, así como realizar el seguimiento de la toma de decisiones.

Por lo tanto, en la tarea de acompañamiento el profesional deberá:

- Obtener información sobre las capacidades y limitaciones de la persona dependiente.
- Coordinarse con los otros miembros del equipo para compartir información y aunar criterios de actuación.
- Tener en cuenta las orientaciones profesionales para el apoyo necesario en las AVD.

Esto obliga al profesional sociosanitario a adoptar los roles de:

- Rol de cuidador
- Rol informativo porque el cuidador detecta problemas y oportunidades funcionando como un centro neurálgico que recibe y busca información para poder entender lo que está ocurriendo dentro de la organización y en el entorno. Es el encargado de transmitir la información del exterior. Del mismo modo, trata de difundir entre los usuarios la información relativa y surgida en el centro.

- Rol de apoyo emocional

3.4.- Intervenciones más frecuentes.

El acompañamiento a las personas dependientes en la institución consiste en entablar un vínculo de ayuda entre el profesional sanitario y la persona usuaria. Esto genera una serie de intervenciones en diferentes áreas de la asistencia

En el ÁREA FUNCIONAL las intervenciones están relacionadas con el desempeño de las AVD. Las intervenciones más frecuentes son:

- Cuidar la imagen personal de la persona usuaria
- Acompañar e la alimentación
- Acompañar en las movilizaciones, cambios posturales, trasferencias y deambulaciones.



En el ÁREA INFORMACIONAL se le orienta a la persona usuaria sobre los recursos y la manera de acceder a ellos. Las intervenciones más frecuentes son:

- Trasmitir información actualizada de las actividades del entorno social (concursos, espectáculos, asociaciones, actividades físicas…)
- Informar sobre los recursos de la institución tanto materiales como humanos como económicos.

En el ÁREA DE RELACIONES SOCALES Y DE COMUNICACIÓN se fomentan las redes sociales y familiares. Las intervenciones más frecuentes son:

- Facilitar las relaciones con la familia y los amigos (teléfono, programa amplio de visitas…)

En el ÁREA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE se mostrará a la persona usuaria las actividades lúdicas. Las intervenciones más frecuentes son:

- Facilitar todos los recursos técnicos disponibles la persona usuaria para que pueda participar en las actividades lúdicas.
- Informar a los ingresados sobre dichas actividades lúdicas y animarle a que exponga y plantee sus propias preferencias.
- Recoger las propuestas de las personas usuarias y tratar de incluirlas adaptándolas a las necesidades de las personas usuarias en la medida de lo posible.

En el ÁREA PSICOEMOCIONAL el apoyo al residente se prestará escuchándolo y potenciando su autoconfianza. Las intervenciones más frecuentes son:

- Facilitar y respetar la expresión de los sentimientos de la persona usuaria.
- Escuchar con respeto
- En caso de dar su opinión la dará de forma respetuosa hacia el usuario y sin imponer su propio criterio.
- Dar pautas relacionales solo cuando sea necesario y siempre respetando la elección de amistades de la persona usuaria
- Apoyar la realización de elecciones



3.5.- Técnicas y actividades para favorecer la relación social.

ACTIVIDADES PARA FAVORECER LA RELACIÓN SOCIAL

Las actividades que se realizan en la institución sociosanitaria tienen múltiples beneficios para los dependientes, no solo tienen como objetivo pasar el tiempo sino que favorecen y dinamizan las relaciones sociales

Desde la animación social, en la institución se pretende ofrecer un abanico de actividades recreativas, culturales, formativas, deportivas, artísticas, de cooperación social, etc., que hagan del tiempo libre algo productivo y beneficioso para los usuarios y para las personas que tienen alrededor.

Algunas de las actividades favorecedoras de las relaciones sociales son:

1. La actividad física que además favorece la oxigenación de la sangre, aumenta el apetito, facilita la digestión, disminuye el exceso de grasa, mantiene el tono muscular y mejora el equilibrio y la fuerza, lo que reduce el riesgo de caídas. El ejercicio físico mejora el estado del cuerpo, en general, y facilita todos los actos de la vida cotidiana, como vestirse, desvestirse, lavarse, etc. También disminuye el estrés y el nerviosismo.
2. Actividades cognitivas: grupos de conversación, lectura, talleres de memoria, debates acerca de temas elegidos por los propios residentes, escuchar la radio, y otras estrategias de aprendizaje para hacer funcionar diversas zonas del cerebro y mantener en mejores condiciones las capacidades mentales
3. Actividades de expresión y comunicación: juegos teatrales, juegos de sociedad, música, juegos de ritmo, danza como terapia, creación de un coro integrado por los residentes, etc.
4. Actividades de artes plásticas y trabajos manuales: dibujos, encuadernación, cerámica, marquetería, grabados, fotografía, tejido de alfombras, modelado, cestería, costura, relieve, collage, pintura, etc.
5. Actividades domésticas: jardinería, cuidado de un huerto o de animales que haya en la residencia (pájaros, peces…), taller de cocina terapéutica, etc.
6. Actividades espirituales: grupos litúrgicos, asistir a oficios religiosos y realizar otros ritos desde el respeto a las tradiciones

TÉCNICAS PARA FAVORECER LA RELACIÓN SOCIAL

Las técnicas que se emplearán para favorecer la relación social en las actividades que se realicen en el centro son:

1. Contacto visual. Con esta técnica se sitúan a los participantes de una actividad de moso que tengan contacto visual entre ellos, en círculo o semicírculo porque con el contacto visual se facilita la comunicación interpersonal.
2. Grupos pequeños porque favorecen la atención especializada, facilita que puedan conocerse todos los integrantes del grupo y da más posibilidades de participación a todos.
3. Metodología cooperativa en lugar de competitiva porque permiten la colaboración de los unos con los otros , el ambiente es más distendido y de este modo es más fácil entablar relaciones .
4. Introducción de asamblea. Se estructuran las sesiones con una disertación inicial donde cada persona usuaria cuenta algo breve, saluda, comenta cómo lleva el día, etc. Al final con la misma técnica cada participante expone un breve resumen de sus impresiones y se despide. Con esta técnica

repromueve la comunicación con el grupo y se refuerza la autoestima porque se le está mandando un mensaje implícito reforzando su presencia.

3.6.- Técnicas básicas de comunicación: individuales y grupales.

La comunicación con los usuarios no siempre es sencilla, no solo por la presencia de déficits que puedan presentar, sino por sentimientos de tristeza que puedan derivar de la propia institucionalización.

En la comunicación hay dos leyes básicas:

1ª Ley: Lo verdadero no es los que dice el emisor, sino lo que entiende el receptor

2ª Ley: La responsabilidad de la comunicación correcta es del emisor

Para conseguir que la comunicación sea eficaz es importante que los profesionales conozcan técnicas para llegar a sus interlocutores tanto a nivel individual como a nivel grupal.

La técnica de comunicación INDIVIDUAL básica es la entrevista. Está dirigida a realizar un intercambio de información para después planificar nuestras intervenciones, es un instrumento importante y que debemos diferenciar de la conversación informal. En la entrevista utilizaremos otras técnicas que faciliten la comunicación: empatía, escucha activa, técnicas asertivas.



Las entrevistas dependiendo del objetivo a alcanzar pueden ser:

- Estructuradas son las que de ante mano llevan las preguntas diseñadas bien sean abiertas, o con opciones (cerradas)
- No estructuradas son las que no llevan preguntas previamente diseñadas.
- Semiestructuradas son las que llevan parte de las preguntas preparadas y otra parte no.

Las técnicas básicas de comunicación GRUPAL son más variadas entre ellas tenemos:

Los grupos de apoyo dirigidos a compartir experiencias, es una de las técnicas que se utilizan en todos los centros socio sanitario. La función del profesional es favorecer las intervenciones de todos los miembros.

Las dinámicas de grupo son técnicas que permiten el afianzamiento de las relaciones interpersonales, ayudan a ejercitar y mantener elementos comunicativos como la expresión verbal, los gestos, ayudan a resolver conflictos, a desarrollar confianza en el grupo etc. Es importante adecuarlas al grupo que tenemos, no son "recetas" que se puedan aplicar en todos los grupos.

Tanto si nos dirigimos de forma individual como si lo hacemos en grupo tenemos que tener en cuenta una serie de ESTRATEGIAS BÁSICAS PARA LA COMUNICACIÓN:

1. Expresar elogios, aprecio y apoyo.
2. Me ha parecido acertado que…
3. Mantener el contacto visual y la mirada directa y no realizar otra actividad al mismo tiempo que la persona habla.
4. Mantener una expresión facial de interés y realizar señales de atención para la persona que habla, como movimientos afirmativos con la cabeza, sonrisas, usar cambios de ritmo y entonación, etc.
5. Hacer eco, es decir, repetir las últimas palabras que ha dicho el usuario y acabar la frase conjuntamente.
6. Realizar murmullos de aprobación, por ejemplo: "ahá…", "umm…" y respuestas de reconocimiento y aprobación: "claro", "ya veo", "te escucho", etc.
7. Reformular, volver a decir o reflejar con otras palabras lo que a la persona le preocupa y ha expresado de forma confusa.
8. Realizar resúmenes aclaratorios: "o sea, que...", "si no he entendido mal,..."
9. Clarificar: realizar preguntas breves para aclarar el contenido de lo que ha expresado si precisamos más información o no entendimos bien el mensaje comunicativo.
10. Empatizar: significa ponerse en el lugar de la otra persona, lo que nos permite sintonizar con los miedos, penas y alegrías del otro; esto nos ayudará a responder en la forma adecuada en la que el usuario nos necesita: "imagino cómo te sientes…", "entiendo que…"
11. No juzgar, no interpretar, no dar órdenes, no dirigir, no mandar, no sermonear, no dar lecciones, no criticar, no infantilizar, no desviar con bromas, etc.; esto dificulta la escucha activa.
12. Olvidar las prisas por responder: no hablar nunca por los usuarios ni adelantar las conclusiones de lo que nos está contando; debemos tener cuidado y no caer en el error de "creernos adivinos"
13. Saludar, presentarnos, iniciar la conversación o introducir el tema contando una anécdota; comenzar la sesión con preguntas abiertas como "¿qué tal estáis hoy?", "¿sabéis lo que me ha pasado?" o "¿qué os parece si empezamos a…?" Se trata de atraer la atención sobre uno mismo y motivar al grupo hacia el tema a trabajar.

14. Mirar a todos (un barrido visual a todos los participantes), porque si solamente hablamos o nos dirigimos a una persona, los demás perderán el interés por lo que decimos.
15. Cuidar los componentes expresivos no verbales, como la sonrisa, el volumen alto, la postura corporal ajustada al contenido verbal que estamos transmitiendo, los cambios de entonación, el contacto físico, etc.
16. Reducir la distancia corporal con los miembros del grupo, sin permanecer en la periferia pero sin introducirnos completamente entre ellos.
17. Introducir contenidos atractivos y que resulten interesantes a la mayor parte del grupo. Para observarlo basta con prestar atención a las expresiones faciales y otras señales de su comunicación no verbal.
18. Ambiente de grupo divertido. Para ello es importante mantener los turnos de palabra, implicar a todos los participantes, evitar las conversaciones entre dos y facilitar la participación dirigida al gran grupo.
19. Esperar las pausas para tomar la iniciativa en la conversación y no hablar antes de que la persona haya terminado.
20. Cuando alguien ocupa todo el espacio comunicativo y no deja hueco a los demás, interrumpirle o cortarle con señales como gestos de la cara, movimientos de manos, etc., cediendo el turno a otras personas para que expresen su opinión.
21. Mencionar el nombre del paciente al que nos referimos y ofrecerle un trato de usted puede resultar respetuoso en el trabajo con personas mayores.

3.7.- Acompañamiento en las actividades.

Tenemos que tener en cuenta que el colectivo de usuarios no siempre resulta fácil de dinamizar, ya que nos vamos a encontrar con problemas de salud, que causan dolor o no tienen una capacidad funcional para realizar muchas tareas, con personas con las funciones cognitivas afectadas, o personas con depresión o ansiedad.

Lo primero que debemos hacer es OBSERVAR a las personas con las que vamos a trabajar para conocer potencialidades, necesidades, preferencias, gustos ... A partir de esta observación planificaremos los OBJETIVOS que queremos conseguir y después pensaremos las ACTIVIDADES que vamos a realizar, y el LUGAR donde van a realizarse y RECURSOS.

Pasos:

- Usuarios a las que van dirigidas las actividades
- Objetivos que se pretenden
- Lugar donde las realizamos
- Recursos materiales y personales

La labor más importante del profesional socio sanitario en el acompañamiento de las actividades es mostrar las actividades, estimular a los usuarios para que las realicen por ellos mismos, devolverles una autoimagen positiva a partir de pequeños

logros y apoyarlos de forma puntual A través del acompañamiento podremos observar al usuario, conoceremos temores, aspectos sobre su autoimagen, sentimientos (tristeza, alegría...) Conoceremos como se relaciona con los compañeros, tensiones que puedan existir entre los miembros del grupo, todo ello supone una información valiosa a la hora de mejorar nuestra intervención con las personas institucionalizadas

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD

1.- María, de 86 años de edad y modista de profesión, siempre se ha caracterizado por ser una persona con una gran red de apoyo social. Desde hace aproximadamente 5 años, que es cuando fallece su marido, se aprecian en ella importantes y visibles cambios psicológicos, tales como aislamiento, soledad, dejadez personal. En general, se encuentra muy desmotivada.

Además, ha comenzado a tener bastantes olvidos, por ejemplo, en la compra de alimentos o en las citas medicas, que le limitan su vida diaria. No tiene familia, ya que nunca tuvo hijos, ni tampoco hermanos, únicamente dos cuñadas que son también de avanzada edad. ¿Qué soluciones encuentras para este caso?

2.- Juan, de 78 años de edad, y Luisa, de 80 años de edad, se encuentran institucionalizados en un centro sociosanitario desde hace aproximadamente 8 años.

Desde que se conocieron, han establecido una buena relación. Los familiares de ambos cada vez muestran más preocupación por esta relación y han hablado con los profesionales del centro para que extremen la vigilancia sobre ellos y, sobre todo, para que eviten cualquier tipo de intimidad entre ambos.

Teniendo en cuenta que los dos se encuentran cognitivamente en plena capacidad de obrar y decidir sobre si mismos, ¿consideras aceptable y beneficiosa la actitud tomada por los familiares? ¿Qué solución, desde el punto de vista profesional, se debería adoptar?

3.- Luis trabaja como gerocultor en un centro de mayores. Un día, un usuario le comenta su desánimo. Le cuenta que en su casa parece que estorba y que en el centro se aburre; que añora cuando trabajaba, pues entonces estaba activo y servía para algo. Luis le pregunta si no se ha planteado transformar su tiempo libre en tiempo de ocio activo, gratificante y productivo. ¿Qué tipo de actividades de ocio puede llevar a cabo una persona mayor?

4.- Héctor se ocupa de la atención domiciliaria de una mujer que acaba de enviudar. Cada vez que la visita, recibe muchas quejas por parte de ella sobre su estado de salud. Cuando le pregunta cuál es el problema, en realidad no le explica nada concreto; más bien aprecia que sus comentarios son muy difusos.

Héctor reflexiona sobre esta situación y decide exponerla a Margarita, que es la coordinadora del servicio. ¿Cuál es la causa de la preocupación de Héctor? ¿Por qué comunica esta situación aparentemente exenta de importancia?

5.- Enumera los tipos de cambios que, a nivel sensorial, se pueden dar durante un proceso normal de envejecimiento.

6.- ¿Cuáles son los cambios que se producen en la conducta sexual, tanto en el hombre como en la mujer?

7.- Expón tres cambios funcionales que se produzcan en la sexualidad del hombre y la mujer mayor.

8.- Un residente que lleva pañal porque sufre incontinencia avisa a la auxiliar de que necesita ir al baño. La auxiliar la contesta que no se preocupe, que lo haga en el pañal y que ella se lo cambiara después. ¿Es correcta la actuación de auxiliar? ¿Vulnera algún límite? En caso afirmativo indica cuál debiera de haber sido la actuación.

9 Test de repaso

1. El gusto y el olfato forman parte del:
   a) Sistema muscular.
   b) Sistema esquelético.
   c) Sistema sensorial.
2. El sistema digestivo forman parte del:
   a) Sistema sensorial.
   b) Sistema orgánico.
   c) Sistema muscular.
3. La teoría de la desvinculación fue formulada por:
   a) Atchley (1971).
   b) Tartler (1961).
   c) Cumming y Henry (1961).
4. No todas las personas mayores poseen la capacidad suficiente como para reorganizar su actividad tras la jubilación. Esta afirmación pertenece a la teoría:
   a) De la desvinculación.
   b) De la actividad.
   c) De la continuidad.
5. Las teorías sobre cambios psicológicos ligados al envejecimiento son:
   a) Teoría de Peck.
   b) Teoría de Erikson.
   c) Las dos alternativas anteriores son correctas.
6. Señala cuál o cuáles de las siguientes son causas de la contracción de la red social:
   a) Mortandad de los miembros.
   b) Aumento de capacidades sensoriales.
   c) Las dos alternativas anteriores son correctas.
7. Los coitos de mayor duración son uno de los cambios sexuales característicos de:
   a) La mujer mayor.
   b) El hombre mayor.
   c) Las dos alternativas anteriores son correctas.
8. El estado psicológico en el que el sujeto se juzga capaz de llevar a cabo una conducta en unas determinadas circunstancias y a un determinado nivel de dificultad, se le denomina:
   a) Autoeficacia.
   b) Indefensión aprendida.
   c) Autoestima.
9. Fomentar la consecución de logros en pequeñas tareas, como logros en el cuidado personal, en la actividad intelectual o en otros aspectos, tienen como consecuencia:
   a) Favorecer la expectativa de vida autónoma.
   b) Favorecer el autoconcepto positivo.
   c) Favorecer la indefensión aprendida.
10. El apoyo integral a las personas mayores les ayudará a:
    a) Satisfacer sus necesidades básicas.
    b) Satisfacer sus necesidades sociales.
    c) Satisfacer sus necesidades básicas, sociales y de autoestima.
11. Es una necesidad psicosocial:
    a) La actividad física.
    b) La comunicación.
    c) Las dos alternativas anteriores son correctas.
12. La estimulación cognitiva forma parte de la:
    a) Atención sanitaria.
    b) Atención higiénica.
    c) Atención psicosocial.
13. La autodeterminación supone:
    a) La capacidad de elegir.
    b) Ser informado con anterioridad.
    c) Las dos alternativas anteriores son correctas.
14. Algunos elementos negativos en el proceso de cambio residencial son:
    a) Cierta pérdida de independencia.
    b) La pérdida del entorno natural.
    c) Las dos alternativas anteriores son correctas.
15. Entre las características del proceso de adaptación de nuestros usuarios a un centro de atención sociosanitario no encontramos:
    a) Es un proceso que cada uno de nuestros usuarios va a realizar de manera diferente ajustándolo a sus peculiaridades.
    b) Es un proceso psicológico que únicamente se refiere al mundo interno del individuo.
    c) Es un proceso que debe relacionar el mundo interno del individuo con el entorno socio-afectivo del mismo.

10.- Une los cuadros de la columna de la derecha con los que les correspondan de la izquierda:

Principio de bienestar	Se debe admitir al usuario tal y como es.
Principio de individualidad	Cada persona tiene derecho a elegir su proyecto de vida.
Principio de aceptación	Toda intervención profesional debe ir dirigida a incrementar el bienestar del usuario.
Principio de autodeterminación	Hay que respetar la confidencialidad de la relación.
Principio de secreto profesional	Cada usuario es único y diferente a los otros.

11.- ¿Qué factores dificultan la adaptación de una persona dependiente a la institución social? Enumera aquellas circunstancias que pueden complicar el proceso de acoplamiento de un usuario a la vida del centro.

12.- ¿Qué se entiende por habilidad social? Señala con una X la opción correcta.

a	La capacidad que tiene una persona para desenvolverse de forma no exitosa en la interacción con otras personas y ajustarse en su medio social.	
b	Está relacionada con la capacidad para expresar sentimientos, insultos u opiniones personales.	
c	Habilidades que dificultan la adaptación del individuo a su entorno.	
d	Es el resultado del aprendizaje continuo que se produce a lo largo de toda una vida.	
e	Las opciones a y d son correctas.	

13.- De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son verdaderas y cuáles falsas?

El envejecimiento fisiológico es un proceso relacionado con la aparición de enfermedades crónicas que están asociadas a una limitación funcional y progresiva que va debilitando la fortaleza del organismo.

Los centros residenciales están destinados a aquellas personas que no cuentan con recursos económicos suficientes para asumir los cuidados especializados que necesitan por ser dependientes.

La capacidad de dar y recibir placer no se deteriora con el paso del tiempo, así como la fantasía, el grado de intimidad, el vínculo amoroso, la consideración afectiva y el deseo hacia la otra persona.

Los asuntos económicos, las tareas del hogar y aquellas actividades que posibilitan a la persona ser autónoma en su entorno son algunas de las actividades básicas de la vida diaria (AVDB).

Una persona vitalista es aquella que vive con entusiasmo y se percibe responsable de su vida, independientemente de que necesite apoyo para determinadas tareas, luchando por cambiar y progresar más allá de sus limitaciones.

Por acompañamiento entendemos una relación de ayuda y de confianza entre un profesional y un usuario construida mediante el contacto, la cercanía, la presencia cotidiana y el compromiso adquirido.

14.- Une con flechas cada tipo de discapacidad con las enfermedades que pueden estar relacionadas:

TIPO DE DISCAPACIDAD	PATOLOGÍAS RELACIONADAS
Discapacidad sensorial.	Bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica,...
Discapacidad física.	Sordoceguera.
Discapacidad psíquica.	Enfermedad mental grave: trastornos psicóticos, trastorno delirante, esquizofrenia,...
Discapacidad física y psíquica.	Enfermedades cerebro - vasculares: parálisis cerebral, daño cerebral adquirido,...

15.- Cita 5 tipos de actividades se emplean en la animación social de la institución y favorecen las relaciones sociales de las personas residentes. Enumera algunos ejemplos de cada una de ellas.

16.- ¿En qué consiste el concepto de acompañamiento a las personas dependientes en sus actividades de la vida diaria?